



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Rehabilitatsiooni teenuseosutajate infopäev

16. oktoober 2020

Rehabilitatsiooni teenuseosutajate infopäev

- 10.30-11.10 Rehabilitatsiooni leping
- 11.10-11.40 ESF programmist ja arendustegevusest
- 11.40-11.55 Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhoosi haigestunud inimesele
- 11.55-12.15 Rehabilitatsiooni arved ja aruanded
- 12.15-12.30 Rehabilitatsiooni arendused
- 12.30-13.30 paus

Rehabilitatsiooni teenuseosutajate infopäev (jätkub)

- 13.30-13.55 Erivajadusega laste tugisüsteemi tulevik
- 13.55-14.15 Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
- 14.15–14.30 Tegevusloa taotlemisel ja muutmisel oluline teada
- 14.30-15.00 Olulised ülevaated rehabilitatsiooni korraldusest
- 15.00-15.15 Eriolukorra õppetunnid ja tagasiside teenuseosutajatelt



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

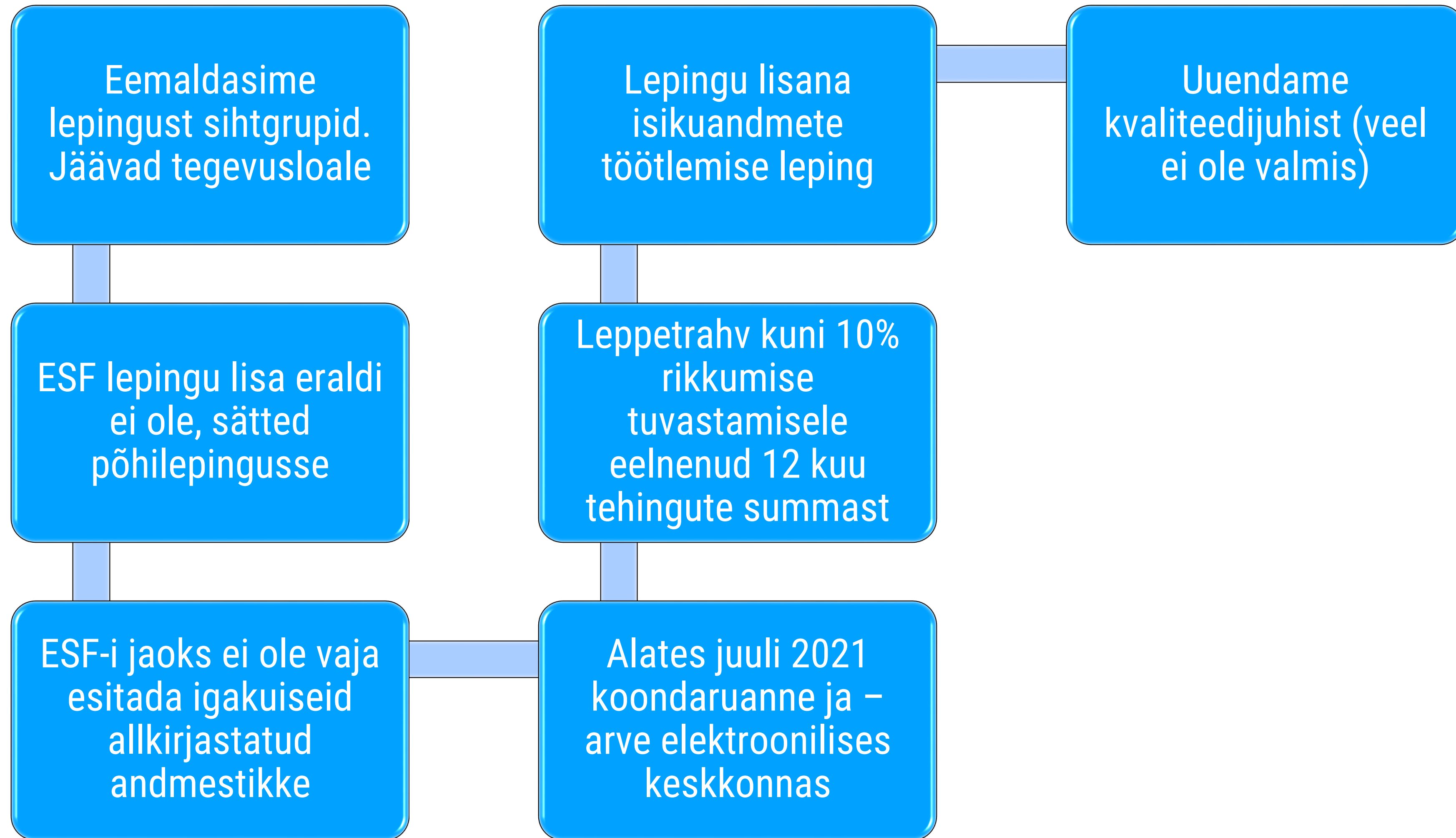
Rehabilitatsiooni leping

Helen Tähtvere

Sotsiaalkindlustusamet

erihoolekande- ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja

Rehabilitatsiooni lepingu peamised muudatused



Teenuse osutamine

Teenuseosutaja küsimus

- Kas asutusel on õigus teenuse osutamisest keelduda?

SKA seisukoht

- Teenuseosutajad teevad oma valiku, kellele nad soovivad teenust osutada hetkel, kui nad otsustavad, millisele konkreetsele sihtrühmale nad hakkavad teenust osutama (vastavalt SHS § 148 lg-le 2 peab teenuseosutaja tooma välja tegevused, mida teenuse raames osutab). Neile inimestele tuleb teenust osutada



Dokumentide säilitamine

Teenuseosutaja küsimus

- Mis saab klientide dokumentidest, kui leping lõpeb ja asutus lõpetab teenuse osutamise ning millised kohustused jäävad asutusele lepingu lõppedes?

SKA seisukoht

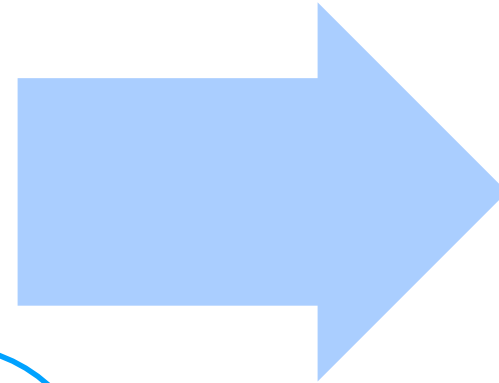
- Punkt 2.1.19. kohaselt tuleb teenuseosutajal säilitada ESF sihtrühma kuuluvate isikute puhul kulu abikõlblikkust tõendavaid seireankeete ja andmestikke kuni aastani 2028. Muud dokumendid raamatupidamise seaduse nõuetele vastavalt.
- Originaaldokumendid tuleb asutusel endal säilitada. SKA küsib täiendavaid dokumente siis kui vaja.



Lepingu lisad

Teenuseosutaja küsimus

- Millised on lepingu lisad ja millal saab nendega tutvuda?



SKA seisukoht

- Kõige olulisemad lisad on kvaliteedijuhis ja isikuandmete töötlemise leping. Ülejäänud lisadeks on ESF dokumentide põhjad ning koondaruande väljade vorm.



MISP2

Teenuseosutaja küsimus

- Mis on sotsiaalhoolekande portaal?
- Kes on sotsiaalhoolekande portaali haldur?
- Millisel õiguslikul alusel sotsiaalhoolekande portaal toimib?
- Millist õiguslikku tähendust omab tellija hinnangul inimese pöördumine TO poole ja sotsiaalhoolekande portaali inimese pöördumise ehk registreeringu tegemine?

SKA seisukoht

- Sotsiaalhoolekande (SHK) portaal on MIS2.
- Haldur on teenuseosutaja poolne vastutav inimene, kelle kohustus on tagada jooksvalt kasutajate andmete uuendamine, sh kasutaja õiguste lõpetamine töötaja töölt lahkumisel, vastavalt tegelikule olukorrale.
- Lisame lepingusse sätte, mille kohaselt on teenuseosutaja kohustatud SHK portaali kasutama.



Rehabilitatsiooniplaani edastamine SKA-le

Teenuseosutaja küsimus

- Teenuseosutaja ei jõua koostada ja SKA-le edastada rehabilitatsiooniplaani 30 kalendripäeva jooksul arvates isiku ja teenuseosutaja vahel lepingu sõlmimisest

SKA seisukoht

- Mm nr 69 § 6 lg 1(1) kohaselt tuleb plaan edastada koos arvega. Muudame lepingus ära 30 kalendripäeva nõude. Rehabilitatsiooniplaan tuleb meile saata hiljemalt koos esimese arvega.



D-osa saatmine

Teenuseosutaja küsimus

- Punkt 2.1.12. esitada teenuse osutamise lõpetamisel enne otsuses märgitud kuupäeva saabumist tellijale rehabilitatsiooniplaani D-osa allkirjastatult ja krüpteeritult hiljemalt koos viimase arvega ei ole rakendatav.

SKA seisukoht

- Nõus, vaatame sõnastuse üle. Mm nr 69 kohaselt tuleb D-osa esitada koos viimase arvega.



Järelepärimised

Teenuseosutaja küsimus

- Kui 2.1.22 kohaselt teenuseosutaja peab SKA järelpärimisele vastama 5 tööpäeva jooksul, siis lepingupoolte võrdsusest lähtuvalt peab sama kohustus vastamiseks olema ka SKA-l.

SKA seisukoht

- Andmete edastamiseks on meil 5 tööpäeva (rehabilitatsiooniplaani ära kiri ja/või rehabilitatsioonivajaduse hindamise küsimustik).
- Kui dokumendid ei ole korrektsed, anname tagasisidet 7 tööpäeva jooksul.
- Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul.



Arvete esitamine

Teenuseosutaja küsimus

- 4.2. Miks on Täitjale antud arve esitamiseks tähtaega ainult 2 tööpäeva?
Raamatupidajate töö võib olla korraldatud nii, et igapäevaselt raamatupidaja ühe firmaga ei tegele ja nii lühike tähtaeg ei ole mõistlik.

SKA seisukoht

- Nõus, määrame arve esitamise tähtajaks kuni 5 tööpäeva.



Lepingu rikkumine

Teenuseosutaja küsimus

- 5.6 Mida tähendab lepingu rikkumine olulisel määral ja millal on lepingu rikkumine korduv? Palun lahti kirjutada.
- Miks on leppetrahvi määra muudetud?

SKA seisukoht

- Olulise lepingurikkumise mõiste sisustamisel lähtume eelkõige VÕS § 116 lg-st 2.
- Leppetrahv kuni 10% rikkumise tuvastamisele eelnenud 12 kuu tehingute summast on SKA lepingute üldine säte.



Teenusele mitte ilmumine

Teenuseosutaja küsimus

- Kuna leping ei käsitle kuidagi olukorda, kus täitja on omalt poolt kõik mõistlikud sammud kliendile teenuse osutamiseks astunud/sooritanud, ent klient jätab kokkulepitud ajal vastuvõtule tulemata siis kuidas planeeritakse maandada vastavast täitjale kaasnevast kulust tulenev risk?

SKA seisukoht

- Kui inimene jätab kokkulepitud ajal teenusele tulemata, ei saa Teie selle eest SKA-le arvet esitada. Inimese vastutuse tõstmiseks ja kindlustamiseks, et Te ei jää plaanitud tasust ilma, soovitame Teil inimesega teenuse osutamise lepingut sõlmides lisada ühe teenuse osutamise tingimusena kahju hüvitamise kohustus inimesele kui ta jätab teenusele tulemata ja Teid sellest ei teavita.



Allhanked

Teenuseosutaja küsimus

- Kas SKA hinnangul võib teenuseosutaja osta mingit teenuse osa sisse ka allhanke korras?

SKA seisukoht

- Allhanked ei ole keelatud. Oluline on, et oleks olemas kokkulepe teise ettevõttega, kelle meeskonna liikmeid laenata soovitakse.
- Kõik teenust osutavad spetsialistid on meeskonna liikmed (MTR tegevusloal), spetsialistidega peab olema sõlmitud lepingud ja kanded TÖR-is.



Rehabilitatsiooni valdkonna aruandlus (p 4.5)

Probleemid, millega iga päev tegeleme:

1. Arvetes ja aruandluses palju „näpuvigu“
2. Aruandlus mahukas
3. Meie spetsialistidel topelt liigutusi palju – topelt kontroll, topelt kinnitamine
4. Arvete ja aruandluse esitamise distsipliin paigast (üle tähtaja, sisulised vead, nõutud dokumendid puudu jne)



Tähelepanek

Teenuseosutaja küsimus

- Punkt 2.1.3. – Teeme ettepaneku muuta sõnastust ning asendada sõna „pakutud“ sõnadega „sotsiaalse rehabilitatsiooni

SKA seisukoht

- Nõus, muudame sõnastust:
- 2.1.3. osutada täitja poolt *sotsiaalse rehabilitatsiooni* teenuseid igale isikule, kes on tema poole pöördunud tellija poolt väljastatud tasu maksmise kohustuse isikult ülevõtmise otsuse (edaspidi otsus) alusel



Teenuseosutaja vahetamine

Teenuseosutaja küsimus

- Punkt 2.1.15
(teenuseosutaja vahetamine mõjuval põhjusel) – arusaamatu tegevuste järjestus, mis ei vasta ka täna tellija tegelikule praktikale ning nimetatud järjestusest tulenevalt ei ole TO-l võimalik järgida sätestatud tähtaegadest kinnipidamist.

SKA seisukoht

- Oleme ettepanekuga nõus, teeme lepingus muudatuse.



Isikuandmed teenuseosutajale

Teenuseosutaja küsimus

- Punktid 2.2.1 ja 2.2.3 -ebaselgeks jääb lepingusse sõnastatud nõue, et täitja edastab teenuseosutamiseks vajaliku info, sh eriliigilisi isikuandmeid ja isiku rehabilitatsiooniplaani ära kirja ja/või rehabilitatsioonivajaduse hindamise küsimustiku vaid juhul, kui täitja seda taotleb ja kui sellele on lisatud isiku nõusolek.
- **Punkt 3.1.1.** –kui pooled ei lepi kokku lepingu punktide 2.2.1 ja 2.2.3 muutmises, siis on käeolev punkt mõttetud, sest sõnastus ei ole vastavuses eelnimetatud punktidega.

SKA seisukoht

- Nõus, muudame sõnastust ja võtame isiku nõusoleku lepingust välja



Teenuseosutaja kontaktid

Teenuseosutaja küsimus

- Punkt 8.4. - tellija on jätnud endale õiguse nimetada lepingus erinevad isikud lepingu täitmise ning arvete ja aruandlusega seotud küsimustes. Sarnane vajadus on ka täitjal. Seega palume, täiendada punkti 8.4.2. alapunktiga 8.4.2.1., lisades sinna teksti: täitja kontaktisik lepinguga kaasnevate arvete ja aruandlusega seotud küsimustes on XXX XXX, tel XXX, e-post XXX või teda asendav isik.

SKA seisukoht

- Nõus, kõik asutused, kes soovivad kontaktisikutes teha erisusi, seda teha ka saavad.



Dokumentide edastamine

Teenuseosutaja küsimus

- Krüpteerimise nõue lepingus läbivalt – juhul, kui dokumendihaldussüsteemi (nt Delta) kaudu edastatud dokumendid vastavad sarnaselt krüpteerimisele turvanõuetele ja võib dokumente edastada dokumendihaldussüsteemi kaudu (DVK) (jälgides nende registreerimisel juurdepääsupiirangu ja selle aluse seadmise nõudeid dokumendihaldussüsteemis), siis palume vastavalt täiendada/täpsustada ka lepingu teksti.

SKA seisukoht

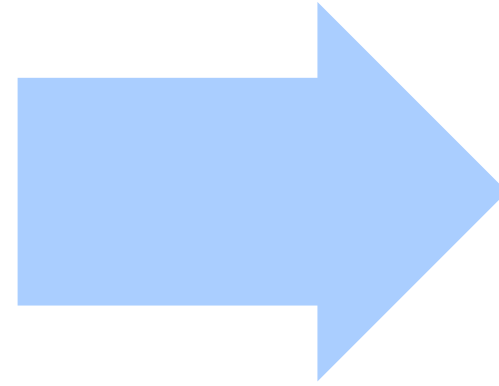
- Nõus, teeme lepingusse täienduse ja asutused, kes kasutavad DVK-d, saavad dokumendid läbi DVK esitada.



Isik ja seaduslik esindaja ja eestkostja

Teenuseosutaja küsimus

- Lepingu punkti 2.2.1 kohaselt on tellijal kohustus anda täitjale enda valduses olevat teenuse osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh eriliigilisi isikuandmeid, kui selleks on olemas isiku nõusolek – Lisada punkti täpsustus, et laste puhul seadusliku esindaja ja isikule seatud eestkoste puhul eestkostja nõusolek.



SKA seisukoht

- Lepingus on läbivalt mõeldud isiku all ka esindajaid ja eestkostjaid.



Kvaliteedijuhis



- ✓ Vaatame kvaliteedijuhise veelkord sisuliselt üle
- ✓ Võtame arvesse Teie esitatud ettepanekud
- ✓ Kutsume Teid videokonverentsi vahendusel arutelule 6. november. Saadame eraldi kutse.



Aitäh!



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

ESF programmist ja arendustegevusest

Felika Tuul
projektijuht

Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele

- **Teenuse kättesaamise kinnitus andmestikul**
 - Valimipõhiselt SKA-le esitades allkirjastab ja kinnitab teenuste kättesaamist teenuseosutaja.
- **ESF tingimustele vastavuse info rehabilitatsiooniotsusel**
 - Määratud puude/tvm kehtivus kooskõlas rehabilitatsiooniotsusega;
 - käesoleval kalendriaastal 16-a saanud lapsed (määrus 66 §3 p1);
 - abivajav laps/KOV hinnanguga isik ei kuulu edaspidi ESF-i.

Avatud Dialoogil (AD) põhinev mobiilne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

- Rehabilitatsiooni teenust osutatakse lapse enda keskkonnas.
- Meeskonnad komplekteeritakse fassilitaatori (hõlbustaja) eestvedamisel lapse individuaalsest olukorrast ja vajadustest lähtuvalt.
- AD kaudu saavutatakse rehabilitatsiooniprotsessis unikaalseid tulemusi läbi grupidünaamiliste tegevuste, protsessi kindlate elementide, rääkimise-kuulamise viiside jm, mis koondavad lapse ja tema pere ning kogu võrgustiku ressursid lapse toetamiseks ühtekokku – selle kaudu luuakse võimalus positiivseks muutuseks.

AD koolitajate koolitusel osalemine ja mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine lastele

- **Koolitajate koolitus (meeskondade koolitus)**
 - Kogumaht 320 ak tundi, sh:
 - auditoorne töö 160 h
(20 koolituspäeva: 5 õppesessiooni x 4 päeva x 8 h);
 - konsultatsioonid, mentorlus, supervisioon 80 h;
 - iseseisev töö 80 h.
- **Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine lastele**
 - Iga osalev meeskond osutab teenust vähemalt 20-le lapsele.

AD-I põhineval mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni hankes osalemine

- Hankega otsime 3 meeskonda – tehnilised nõuded hankedokumentatsioonis.
- Iga osalev asutus komplekteerib 5-liikmelise mobiilse SRT meeskonna.
- **Meeskonnaliikmete kvalifitseerimistingimused:**
 - omandatud esimese astme kõrgharidus (bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus) sotsiaal-, haridus- või tervise valdkonnas;
 - vähemalt 1-aastane töökogemus laste sihtrühmaga (rehabilitatsioon, sotsiaaltöö, lastekaitse, haridus, tervis).
- **Meeskonna kvalifikatsioon:**
 - Erinevad kompetentsid: nt nõustamise, meeskonnatöö, sh juhtimise, konfliktitöö, pereteraapia, tervise- edenduse, koolituse jm oskused.
 - Meeskonnaliikmete olulised isikuomadused: empaatia, kannatlikkus, isiklik domineerimisvajadus on maandatud.



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Aitäh!

Felika.Tuul@sotsiaalkindlustusamet.ee



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhhoosi haigestunud inimesele

Eva Kliiman

erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse arendusspetsialist

Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhhoosi haigestunud inimesele

- 2016-2018 piloteerisid Tallinna Vaimse Tervise Keskus koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku integratiivravi osakonnaga integreeritud teenuseosutamist skisofreeniasse esmahaigestunutele
- SHSi muudatused on juba jõustunud
- Muudatuse rakendamine ettevalmistamisel



Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhhoosi haigestunud inimesele

- Eesmärk kujundada esmasesse psühhhoosi haigestunule meditsiinisüsteemist sujuv üleminek sotsiaalsüsteemi
- Sihtgrupp:

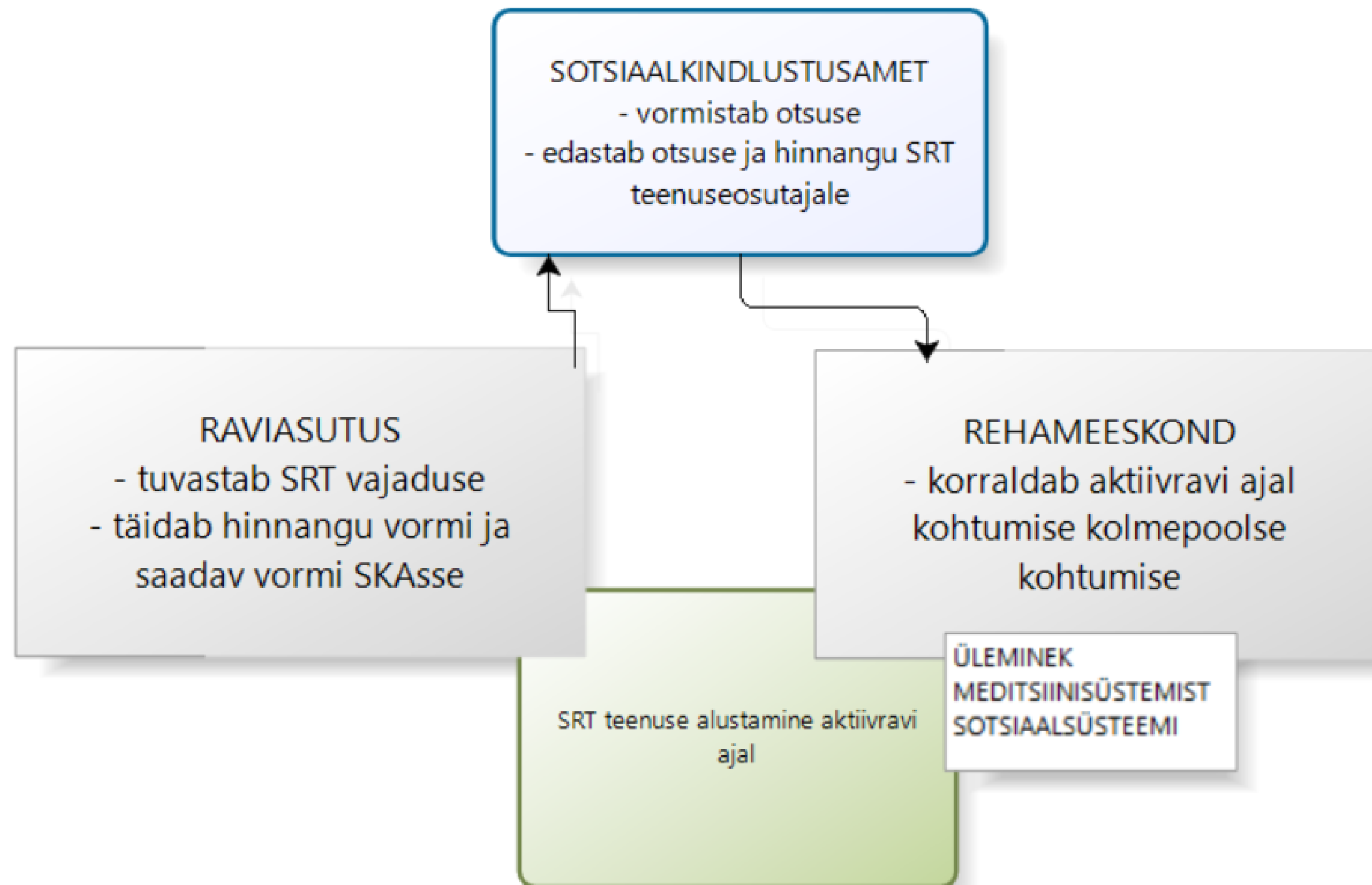
kellel on esmakordselt diagnoositud psühhhoos (skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired RHK-10 kohaselt diagnooside grupis F20-F29);

kes vajab edasist toetamist nii tervishoiu kui sotsiaalvaldkonna poolt.

- Töö motivatsiooni kasvatamisega on osa sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest, ent abi taastumise järjepidevuse tagamiseks on oluline, et rehabilitatsiooniprotsessiga oleks võimalik alustada enne, kui inimene on valmis aktiivselt abi taotlema.



Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhhoosi haigestunud inimesele





SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Aitäh!

Eva Liina Kliiman

eva.kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

REHABILITASIOONI ARUANDED JA ARVED

Liina Olgo

juhtivspetsialist

erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitus

16.10.2020

Meeldetuletus

- 1001 koodi kasutada ainult rehabilitatsiooniplaani koostamisel

Rehabilitatsiooniplaani lisa ja täiendatud tegevuskava ei saa rahastada 1001 koodi alt. Need tuleb kajastada spetsialistide ridade alt, keda kaasate protsessi.

- Kirjalike järelepärimistele vastamine 5 (viie) tööpäeva jooksul

Näiteks:

- andmestike esitamine
- aruannete, arvete või lisadokumentide parandamine

Me ei saa enne aruannet ära kinnitada ja arvet maksta, kui alusdokumendid pole korrektsed.

Olukord täna

- Iga kuu 5000-6000 SRT aruannet ja 5000-6000 SRT arvet.
- Umbes 20% SRT aruannetest ja arvetest vigased või puudu alusdokumendid.
- Teenuseosutajad esitavad SKA-le iga inimese kohta eraldi aruande ja ka eraldi arve.
- SKA spetsialist peab ära kontrollima iga inimese osas eraldi aruande ja ka iga inimese osas eraldi arve.
- Topelt töö nii teenuseosutajale, kui ka SKA-le.

Soovime protsessi mugavam ja kasutajasõbralikumaks nii teenuseosutajale, kui ka SKA-le.

Koondaruanne- ja arve

Oleme välja töötanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste koondaruande põhja excelis neile, kes ei kasuta sobivat ja toimivat infosüsteemi.

Koondaruande Exceli faili nimi väga oluline

Oktoobri kohta näiteks: Teenusosutaja nimi_koondaruanne_10.20

Hiljem koondarvel teenuse nimetuse alla tuleb lisada koondaruande faili nimi (siiani olete lisanud sinna reale suunamisotsuse numbri K000....)

NB! Koondaruande puhul on faili pealkiri väga oluline ja see peab olema hiljem koondarvel teenuse nimetuse real oleva nimega täpselt samasugune – et saaksime koondaruande ja –arve hiljem ka omavahel siduda.

Pealkiri on näiteks oktoobri kohta:

Teenuseosutaja nimi_koondaruanne_10.20 ja koondarvel peab teenuse nimetuse real kajastuma täpselt see sama faili nimi.

Koondaruanne (exceli 1. leht)

Teenuseosutaja	asdfgh	Aruande koostaja nimi:		qwertyy	E-mail:	asdf			
Registrikood	123456	Allkirjastatud digitaalselt		allkirjastatud	Telefon	293847			
RE/ESF (TÄIDAB SKA MENETLEJA)	Otsuse number	Teenuse nimetus	Teenuse kood	Teenuse osutamise ajavahemik		Teenuse maht tundides	Teenuse tunni / päeva hind	Teenuse hind kokku	Jätkub JAH/EI
				Algus	Lõpp				
		Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine	1001				64,94	0,00	Jah
		Füsioterapeudi individuaalteenus	2001				26,94	0,00	
		Füsioterapeudi grupiteenus	2002				9,57	0,00	
		Tegevusterapeudi individuaalteenus	2003				27,06	0,00	
		Tegevusterapeudi grupiteenus	2016				10,12	0,00	
		Loovterapeudi individuaalteenus	2019				26,45	0,00	
		Loovterapeudi grupiteenus	2021				8,79	0,00	
		Sotsiaaltöötaja individuaalteenus	2004				24,71	0,00	
		Sotsiaaltöötaja grupiteenus	2006				8,82	0,00	
		Eripedagoogi individuaalteenus	2007				26,18	0,00	
		Eripedagoogi grupiteenus	2009				9,30	0,00	
		Psühholoogi individuaalteenus	2010				26,97	0,00	
		Psühholoogi grupiteenus	2012				9,63	0,00	
		Logopeedi individuaalteenus	2013				27,31	0,00	
		Logopeedi grupiteenus	2015				9,72	0,00	
		Kogemusnõustaja individuaalteenus	2022				18,83	0,00	
		Kogemusnõustaja grupiteenus	2024				6,93	0,00	
		Õe individuaalteenus	2025				25,71	0,00	
		Õe grupiteenus	2027				9,13	0,00	
		Arsti individuaalteenus	2028				38,15	0,00	
		Ööpäevaringne majutus	3001				23,97	0,00	
		Ööpäevaringne majutus alla 16-a. isiku esindajale	4003				18,22	0,00	
		KOKKU SRT TEENUSTE SUMMA				0,00		0,00	

Koondaruande täitmine

Esimesena on vaja täita exceli esimesel lehel üleval olevad andmed:

- Teenuseosutaja nimi
- Registrikood
- Aruande koostaja nimi
- Telefon
- E-mail

Koondaruande täitmine

Koondaruandesse lisada kõik kuu jooksul teenust saavad inimesed. **Exceli tabelis on ära märgitud helesinise värviga lahtrid (valgeid lahtreid mitte täita), mis on mõeldud täitmiseks:**

- Otsuse number

Lisaselgitus: sinna märkida otsuse number K000..... Igasse plokki märkida ühe korra helesinisele alale suunamisotsuse number.

- Teenuse osutamise ajavahemik – algus ja lõpp

Lisaselgitus: Kuupäeva saab kirjutada ainult ühes vormingus, teisi vorminguid exceli koondaruande tabel ei luba. Vorming on pp.kk.aa ehk nt algus 03.08.20; lõpp 17.08.2020

- Teenuse maht tundides

- Jätkub JAH/EI

Lisaselgitus: seal lahtris olema valikvariant noolega – JAH või EI. Automaatselt on tabelis olemas kõigil jah. Igasse plokki märkida ühe korra helesinisele alale suunamisotsuse number.

Koondaruande täitmine

Järgnevad lahtrid on exceli tabelis lukus ja neid ei saa muuta ega üle kirjutada:

- Teenuse nimetus
- Teenuse kood
- Teenuse tunni/päeva hind
- Teenuse hind kokku

MIKS lukus: Et viia miinimumini vigade arv, kogemata muudatekase ära kood või nimetus, ei tekiks kokku arvutamise vigu.

Koondaruanne (exceli 2. leht)

Teisele lehele kuvab Excel automaatselt andmed

Teenuseosutaja:	asdfgh		
Registrikood:	123456		
SRT kliente	0		
Summa kokku	- €		

Koondarve

Kui SKA spetsialist on ära kontrollinud koondarve, siis ta annab sellest e-maili teel teada teenuseosutajale ja annab vajaliku info, mis on oluline märkida koondarvele.

- Arve number
- Teenuse nimetuse alla tuleb lisada koondaruande faili nimi (siiani olete lisanud sinna reale suunamisotsuse numbri K000....)
- Koondarve sisusse järgnev info:
 - Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse eest osutatav kogusumma (täpse summa lisab SKA spetsialist e-kirja)
 - SRT teenuseid saanud inimeste arv (täpse arvu lisab SKA spetsialist e-kirja)



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Aitäh!

Liina Olgo

liina.olgo@sotsiaalkindlustusamet.ee

telefon: +372 5324 2101



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Rehabilitatsiooni arendused

SRT koondaruande ja koondarve kasutusele võtmine

Raivo Piiritalo
Teenuste osakond
Äriteenuste nõunik

Probleem

Teenuseosutaja:

Arvete väljamaksmised hilinevad.
Arvete aluseks olevate aruannete ja
lisadokumentide esitamine on käsitöö
Iga isiku kohta tuleb igakuuliselt esitada
arve.

Teenuse saaja:

Puudub ülevaade mis teenuseid on osutatud.
Puudub ülevaade aasta teenuseliimiidi ja
piirmäärade kasutusest

SKA:

Esitatud aruannetes palju vigu ja arvete
väljamaksmised hilinevad
Aruande ja arve menetlusprotsess on
käsitöö.

SRT koondaruande ja koondarve kasutusele võtmine

TÄNANE OLUKORD				HOMNE OLUKORD	
	TO täidab käsitsi aruande	TO kasutab SKA excel lahendust koondaruande täitmisel (piloot)	TO koostab elektroonilises keskkonnad koondaruande	TO koostab elektroonilises keskkonnad koondaruande	Automaatne andmevahetus infosüsteemide vahel
Statistika	51 asutust (45,54% asutustest) Asutuste 2019 a käive kokku 2 420 727€ (22,67% kogukäibest)	9 asutust (8,04% asutustest) Asutuste 2019 a käive kokku 808 012€ (7,57% kogukäibest)	52 asutust (46,43% asutustest) Asutuste 2019 a käive kokku 7451519€ (69,77% kogukäibest)	112 asutust (100% asutustest) Asutuste 2019 a käive kokku 10680258€ (100% kogukäibest)	112 asutust (100% asutustest) Asutuste 2019 a käive kokku 10680258€ (100% kogukäibest)
Tähtajad		Piloot algas augustis. Kõik kes täidavad aruannet käsitsi on oodatud liituma		Ajavahemikul, juuli 2021 kuni oktoober 2021, hakkavad kõik asutused esitama elektroonilises keskkonnas ettevalmistatud isikupõhist koondaruannet	Tulevikus
Aruande esitamise vead	1. Näpuvead aruandel, summad ei klapi, koma kohad valed, teenuse hind vale 2. Puudub teenuse rahastamise õigustatus 3. Teenuse limiitide ja piirmäärade ületamine 4. Puuduvad arve aluseks olevad lisadokumendid	1. Puudub teenuse rahastamise õigustatus 2. Teenuse limiitide ja piirmäärade ületamine 3. Puuduvad arve aluseks olevad lisadokumendid	1. Üksikud isiku otsuse pealt andmete käsitsi infosüsteemi sisestamise vead 2. Puuduvad üksikud arve aluseks olevad lisadokumendid	1. Üksikud isiku otsuse pealt andmete käsitsi infosüsteemi sisestamise vead 2. Puuduvad üksikud arve aluseks olevad lisadokumendid	1. Võivad esineda üksikud vead isiku õigustatuse, limiitide, piirmäärade ja lisadokumentide osas. 2. TO infosüsteemile antakse koondaruande andmete vastuvõtmisel veateade kui viga tuvastatakse. Koondaruanne kinnitatakse kui viga on parandatud.

Teenuste juhtimise infosüsteemid rehabilitatsiooniasutusele

VAADE: ÜLEVAADE MARI TEENUSTE PLAANIMISEST AASTA JOOKSUL

Kliendikaart

Andmestik

Juhtumise plaanimine

Limitit

[Muuda plaani](#)

← 2020-01-01 - 2020-12-31 →

Vaheta rahastusotsust: KOOSTEST

REH Üldesmärk

Igapäevaelu valdkonnas suurendada motivatsiooni ja valmisolekut jõukohaseks osalemiseks kogukonna tegevustes, arendada kognitiivseid ja füüsilisi võimeid ning õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, mille tulemusena inimene elab võimalikult iseseisvalt

REH üldesmärgi täpsustus: Igapäevaelu valdkonnas õppida juhtima emotsioone nii, et RO lõpuks oskaks 5 eneseregulatsioonitehnikat.

REH Alameesmārgid: Alameesmārk 1

Teenus	Teenuse osutaja	Jaanuar 2020	Veebruar 2020	Märts 2020	Aprill 2020	Mai 2020	Juuni 2020	Juuli 2020	August 2020	September 2020	Oktoober 2020	November 2020	Detsember 2020	Kokku tunnid	Kokku raha
Eripedagoogi individuaalteenus	Siim Rebane	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20.00	426.80€
Loovterapeudi individuaalteenus	Anna Toots	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	4	2	16.00	347.04€
Psühholoogi individuaalteenus	Laura	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	40.00	875.20€
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus	Kadri Vilgats	2	2	2	2	2	1	0	1	2	2	2	2	20.00	402.80€
Kokku tunnid		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	8.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	96.00	
Kokku raha		213.16€	213.16€	213.16€	213.16€	213.16€	20.14€	0.00€	151.04€	214.56€	214.56€	214.56€	171.18€		2,051.84€
Pearaha jääk															528.16€

Teenuste juhtimise infosüsteemid rehabilitatsiooniasutusele

+

reha.ee
v 1.8.23

Töölaud

Kliendid

Broneeringud

Tegevuskavad

Kanded

Arved

?

⚙

👤

Tegevuskava K00000000 | Janno Kolmrist 51901010000

ÜLDOSA A - KLIENDI ANDMESTIK B - TERVISEOLUKORD C - TEGEVUSKAVA TEENUSE ANDMESTIK D - HINNANG

Juhtum [02.07.2020] (01.01.2020 - 31.12.2020) | Aktiivne

⊕ Loo uus juhtum 📄 Pdf

Limiit	Kasutatud	Eelarve	Jääk		
2 580,00 €	0,00 €	701,30 €	1 878,70 €	Ava juhtum muutmiseks	Määra juhtum lõpetatuks

Teenus	Maht	Hind	Kokku	Kasutatud (€) ⓘ	Jääk ⓘ	
1001 Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (Individuaal)	5,00 h	64,94 €	324,70 €	0,00 €	0,00 €	⊕ Kanne
2022 Kogemusnõustaja teenus (Individuaal)	20,00 h	18,83 €	376,60 €	0,00 €	2 203,40 €	⊕ Kanne
3001 Ööpäevaringne majutus (Individuaal)	5,00 p	23,97 €	119,85 €	0,00 €	0,00 €	⊕ Kanne

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatav üksikteenus (teenus), tegevus või meede

✎ Ava muutmiseks

Teenus	Maht	Eesmärgid	Tegevused
1001 Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine (Individuaal)	5,00 h	Teenuse eesmärk	Kuidas eesmärk saavutatatakse
2022 Kogemusnõustaja teenus (Individuaal)	20,00 h	Teenuse eesmärk	Kuidas eesmärk saavutatatakse
3001 Ööpäevaringne majutus (Individuaal)	5,00 p	Teenuse eesmärk	Kuidas eesmärk saavutatatakse

Allkirjastajad

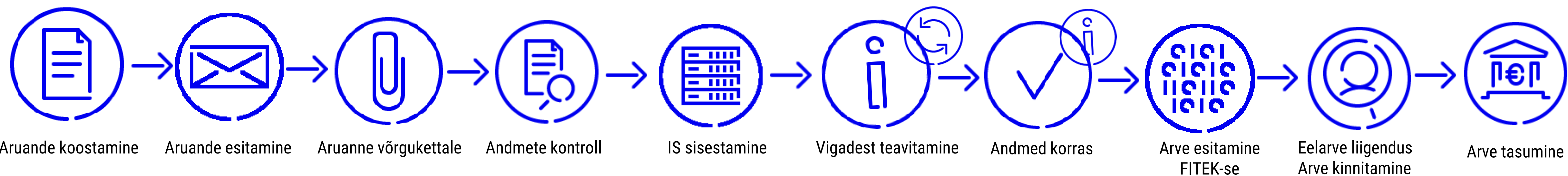
JANNO KOLMRIST janno.kolmrist@brightspark.ee

Lepingupunkti 4.5 lisa

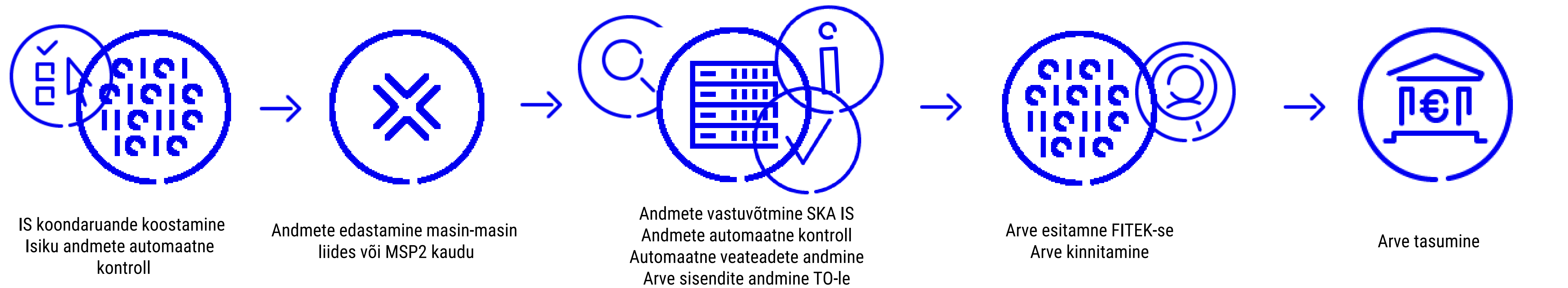
- Perioodi juuli 2021 kuni oktoober 2021 jooksul kohustub täitja võtma kasutusele lisa XXX ja esitama edaspidi tellijale isikupõhise elektroonilises keskkonnas ettevalmistatud koondaruande. Pärast tellija poolt saadetud kinnitust aruandluse korrektsuse kohta, esitab täitja tellijale 2 tööpäeva jooksul koondarve, mis vastab raamatupidamise seaduses kehtestatud nõuetele. Tellija tasub täitjale esitatud koondarve eest üks kord kalendrikuus.
- [Lepingu lisa hakkab koosnema;](#)
 1. koondaruande ja koondarve üldistest nõuetest
 2. elektroonilises keskkonnas ettevalmistatud koondaruande nõuetest
 3. koondaruande Exceli failivormingu näidise

SRT arve aluseks oleva aruandluse menetlusprotsessi automatiseerimine

Tänane- ja soovitud olukord



Käsitöö



Automatiseeritud



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Raivo.Piiritalo@sotsiaalkindlustusamet.ee



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

PAUS

12.30-13.30



SOTSIAALMINISTEERIUM

Erivajadustega laste tugisüsteemi tulevik

Marge Hindriks

Sotsiaalministeerium/ laste heaolu osakonna nõunik

16.10.2020

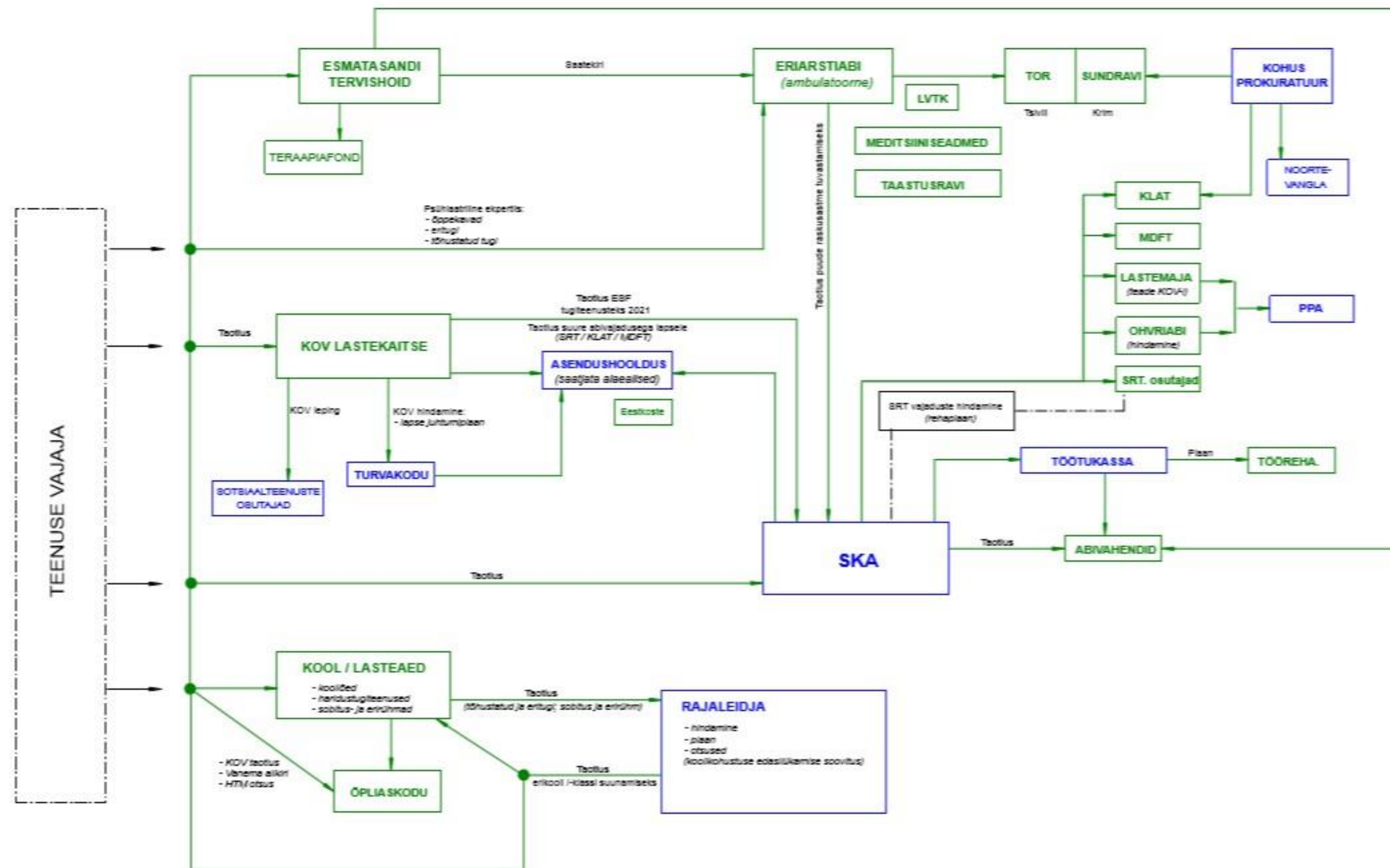
Peamised eesmärgid

Laste ja perede
vajadused on
tuvastatud õigeaegselt.

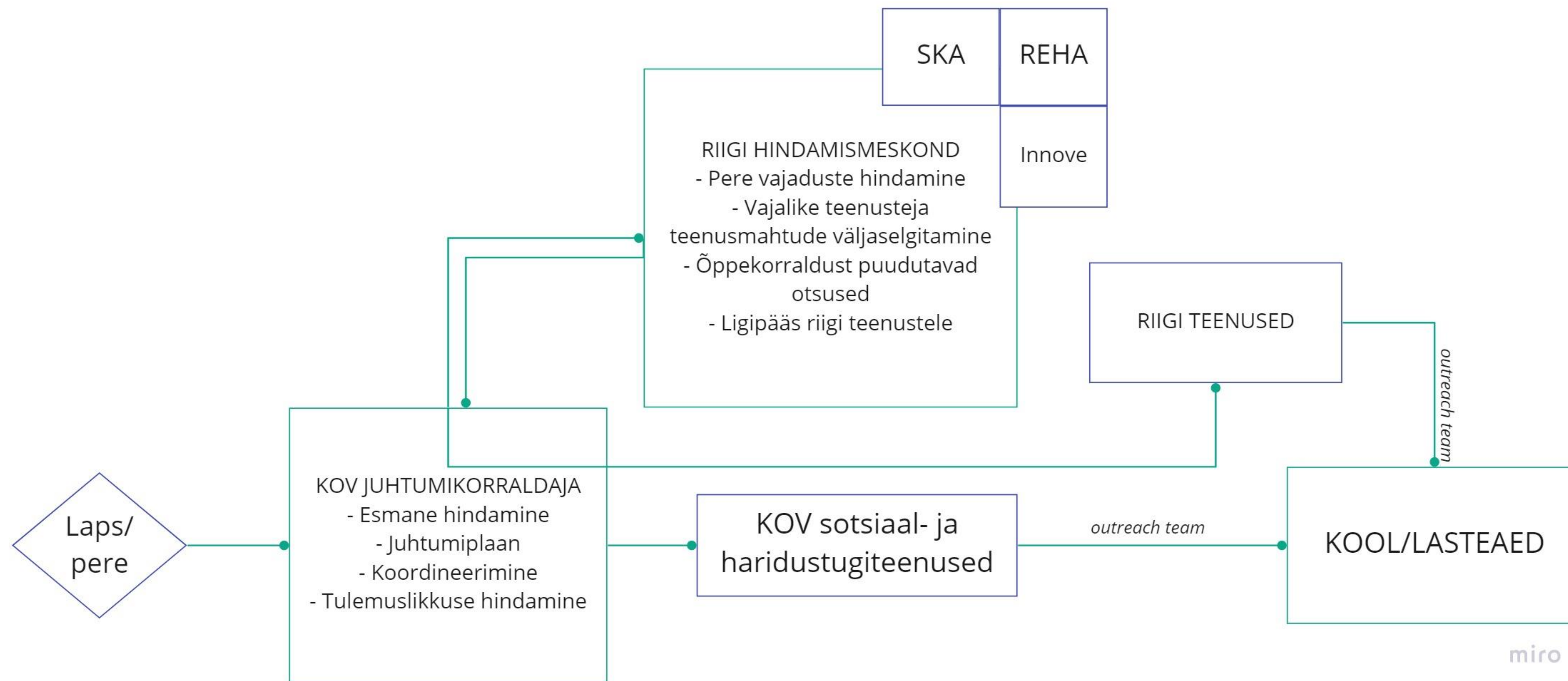
Laste ja perede
abivajadust
vaadeldakse tervikuna,
vähendades hindamiste
ja teenuste killustatust.

Lapsed ja pered saavad
piisavas mahus eri
valdkondade tuge lapse
peamises igapäevases
keskkonnas.

Tänane tugisüsteem



Uus mudel teenuste saamisel



Erivajadustega laste tugisüsteemi muudatused



Puude raskusastme tuvastamine



Teenuste lahti sidumine puudest



Sotsiaal- ja haridusvaldkonna hindamise ja toe integreerimine



Pilootprojekt



Teenuste kättesaadavus ja arendus



Spetsialistide ressurss



Märkamine ja infovahetus



KOV võimekus

Vastutajad

SOM, SKA

Puude raskusastme tuvastamise metoodika kohandamine, valideerimine ja kasutusse võtmine.

PISTS määruse täiendamine laste funktsioonide hindamise osas.

PISTS üle vaatamine ja täiendamine tervikuna.

SOM, RAM

SHS erisust lubava sätte tegemine, mis lubaks rehabilitatsiooniteenused lahti puude olemasolust.

Pilootprojekt.

KOV kohustuste ja võimekuse finantsanalüüs.

Reha paketi muudatused.

Toetusfondi määruse muudatused.

SHSi sätteid tulenevalt KOV kohustustest.

SOM, SKA, HTM, Innove, RAM, ELVL

Rajaleidja, SKA ja rehabilitatsioonimeeskonnade funktsioonide kaardistus ja võimalik ühendamine.

Meeskonnaliikmete vajaduse väljaselgitamine. (SHS, PGS)

Koostöökokkulepe KOVidega. (ELVL)

SOM ja HTM Toetusfondi määruste analüüs ja võimalikud muudatused eelarvete paremaks ühendamiseks.

Kogupäevakooli mudeli väljatöötamine.

SOM, SKA, HTM, Innove, ELVL

Piirkonna ja sihtgrupi kokkulepped. Klienditeekonna disain.

Kokkulepe HTMi ja Haridusametiga; koostöökokkulepe KOVdega.

Hindamisinstrumendi ja tööjuhiste välja töötamine kohandamine

Rehabilitatsiooniteenus pakkumine ilma puude tuvastamiseta.

Tulemuste analüüs ja ettepanekud süsteemi muudatusteks.

SOM, RAM, SKA, ETK

SHS teenuste kriteeriumide väljatöötamine ja vastavate määruste loomine (tugiisiku-, lapsehoiu- ja õendusteenuse arendus). (SHS, PGS)

Riigi ja KOV teenuste jaotus.

Klienditeekondade fikseerimine.

Uute rehabilitatsiooniprogrammide ja teiste riiklike sekkumiste väljatöötamine.

Järelevalve tõhustamine.

Asenduskohustuse võimalikkuse analüüs ja regulatsioon.

SOM, SKA, HTM, EHK

Spetsialistide olemasolu ja tööjõu vajaduse analüüs (OSKA).

Spetsialistide tööülesannete ülevaatamine ja liigse bürokraatia vähendamine.

Spetsialistide haridusnõuete ja kutse uuendamine.

Spetsialistide koolitustellimuse ja tasustamispõhimõtete ettepanekud.

SOM, SKA, HTM, EHK

Puude taotluse vormi täiendamine võimaldamaks edastada andmed KOVile.

Koolivalmiduse kaardi täiendamine.

Kooliõdede roll.

Perearsti kvaliteedisüsteemi indikaatorite lisamine.

STAR, EHIS-e ja perearstide töölaua arendused (info abivajava lapse kohta, tööprotsesside toetamine ja statistika).

Abivajavat last puudutava andmevahetuse sätete täiendamine (LasteKS)

SOM, SKA, KOV-d, UT

Juhtumikorraldaja funktsiooni ja pädevuste kirjeldamine.

Tööprotsesside kujundamine ja tööriistade loomine (STAR arendus).

Lastekaitse baas-täiendus ja kutseõppe uuendamine.

KOV kohustuste ja võimekuse analüüs.

Mustandmaterjal asutusesiseseks kasutamiseks

Aitäh!



Abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

Laura Kane ja Simone Epro
teenuse koordinaatorid

Ohvriabi ja ennetusteenuste osakond, ennetustalitus

Teenusele õigustatus

- Enne 2018. a oli teenusele suunamise aluseks Alaealiste komisjoni otsus (Alaealise mõjutusvahendite seaduses oli SRT ühe mõjutusvahendina).
- 2018. aasta alguses jõustus SHS-i täiendus, mille järgi on teenusele saamise eelduseks abivajaduse tuvastamine.

KOV lastekaitse hindab, et tegu on Lastekaitseseaduse järgi abivajava lapsega (§ 28). Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu.

KOV määrab kindlaks abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse ainult juhul, kui samal ajal on täidetud kaks järgmist tingimust:

- Lapsele on pakutud I tasandi teenuseid (haridusvaldkonna tugiteenused, tervishoiuteenused, KOV sotsiaalteenused), kuid need ei ole lapse abivajadust olulisel määral vähendanud.
- KOV lastekaitse spetsialist hindab last SRT hindamisvahendi järgi, tal tuvastatakse mitmes heaoluvaldkonnas puudujääke (kompleksse sekkumise vajadus)

a) füüsiline või tervislik seisund;

b) psühholoogiline või emotsionaalne seisund;

c) sotsiaalne seisund;

d) kognitiivne või hariduslik seisund.

Teenuse sihtrühm

- Lastekaitse seaduse järgi abivajav laps, kuni 18-aastane.
- KOV on STARis avanud juhtumimenetluse, koostanud juhtumiplaani ja täitnud hinnanguvormi.
- Abivajaduse tunnused:
 - ✓ perevägivalla otsene või kaudne kogemine või muud traumatiseerivad kogemused;
 - ✓ õigusrikkumiste toimepanemine või nende ohvriks langemine; sõltuvusainete tarvitamine (narkootilised ained, alkohol, retseptiravimid, toksikomaania, digisõltuvus);
 - ✓ raskused koolikohustuse täitmisega; agressiivne käitumine; kõrge riskiga seksuaalkäitumine;
 - ✓ suitsidaalne käitumine või muul viisil ennast ohtu seadev käitumine; vaimse tervise probleemid; psühhosotsiaalse toimetuleku probleemid; käitumis- ja psüühikahäired; probleemid peres (vanemate sõltuvushäired, lähedaste vaimse tervise probleemid, konfliktid suhted, vähene vanemlik tugi ja järelevalve).

Teenusele suunamine

- Teenusele suunab KOV lastekaitsetöötaja, kes abivajava lapse puhul täidab STARis juhtumiplaani ja SKA kodulehel abivajava lapse SRT teenuse hinnanguvormi (kaheks heaoluvaldkonnas 2 p = teenusele õigustatus).
- Dokumentide edastamine toimub läbi STAR keskkonna.
- Peale SKA peaspetsialisti poolt positiivse otsuse lisamist STAR keskkonda, valib KOV koostöös lapse perega teenuseosutaja, võtab temaga ühendust ja registreerib lapse teenusele.
- KOVi lastekaitse spetsialist jääb ka edasi lapse juhtumikorraldajaks ning teenuseosutaja hakkab temaga koostööd tegema.

Teenuse arendamise teekond

2020 aasta jaanuarist on abivajava lapse SRT arendus toodud Teenuste osakonnast Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna ennetustalitusse, selleks et näha kompleksprobleemidega laste liikumist teenuste vahel ning luua eel- ja jätkutoe süsteem MDFT, KLAT ja SRT teenuste vahel.

- *Tihti on kompleksprobleemidega lapsed kogenud oma elus psühholoogilist traumat (hülgamine, vägivald, surm jpm), mille tulemusena on neil tekkinud vaimse tervise probleemid, mis õigeaegse ja asjatundliku sekkumise ära jäämise tõttu võivad anda tõuke riski- ja rikkumiskäitumise väljakujunemisele.*

2020 esimesel poolaastal (SRT, MDFT, KLAT) teenused numbrites

Kuu/teenus	SRT	MDFT	KLAT
jaanuar	26	6	6
veebruar	16	17	6
märts	15	8	8
aprill	7	9	5
mai	16	9	8
juuni	17	10	8
Teenusele läinud I	87 (96 otsust)	59	41

Tagasiside rehabilitatsiooni teenuseosutajatele

Mõistmaks, kui suur on teadlikkus lastekaitsetöötajate ja teenuseosutajate seas abivajava lapse sihtgrupist ning neile teenuse pakkumisest, koostasime teenuseosutajatele (veebruar 2020) ja KOVi lastekaitsetöötajatele (märts 2020) küsimustikud.

- Küsimustikule vastas 21 rehabilitatsiooniasutust (38 asutust kokku).
- Lastekaitsetöötajad üle Eesti (igast maakonnast).

Kes on lastekaitsetöötajate ja teenuseosutajate vaates abivajav laps SRT-l

Lastekaitse töötajad: Koolikohustuse mittetäitmine – kõige levinum abivajaduse põhjus KOVide hinnangul.

Alaealised, kes on rikkunud seadust, riskikäitumisega noored, käitumis- ja keskendumisprobleemidega noored, kodus mitteviibivad noored, ennastkahjustava käitumisega ja sõltuvusprobleemidega noored. Vähese pere toega, väärkohtlemise ohvrid, sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemidega noored.

Teenuseosutajad: Alaealised, kes on rikkunud seadust, sõltuvusainete kasutajad. Noored, kellel on raskused koolikohustuse täitmisega, mitterahuldav õppeedukus ja käitumine, impulsiivne, agressiivne käitumine. Hooletusse jäätud lapsed, vägivalda kogenud, asenduskodus kasvavad (hülgamist kogenud lapsed). Väheste vanemlike oskustega ja sotsiaalsete probleemidega vanemate lapsed (psüühikahäirega vanem).

Tegevused teenuse arendamiseks

- Lisaks küsimustikele KOVi lastekaitsetöötajatele ja teenuseosutajatele oleme küsinud tagasisidet ka 32-lt lapsevanemalt, kelle lapsed on saanud abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Uurisime, mis on tänased teenuse saamise kogemused ja milliseid murekohti nad rehabilitatsiooniteenuse juures näevad.

Tagasiside lapsevanematelt

- „Ainuke mure oli see, et teenuseosutaja asus mandril ja töö kõrvalt oli üsna raske aega planeerida, et teenusel regulaarselt käia.“
- „Rehabilitatsiooniprotsess võiks olla lihtsam ja kiirem, liiga palju põhjendamist igale poole, mis probleemid lapsel on.“
- „Kasutegur oli suur. Aga teenuse raames võiks korraldada ka lapsevanematele lühikoolitusi. Samal ajal kui laps on näiteks spetsialisti vastuvõtul võiks olla lapsevanematele mingi programm või lühikoolitus, osaleksin seal hea meelega.“
- „Teenuse osas oleks võinud teisiti olla see, et psühholoog oleks pidanud tegelema lapsevanematega ja neid nõustama (seda ei toimunud). Stabiilsus ja rütm puudus, et oleks teenus olnud järjepidev, siis oleks see ka ehk aidanud.“
- „Teenuse juures ei oska muuta midagi, kõik oli paindlik, teenus oli ema sõnul tulemuslik ja ema ütleb, et ta ise oli ka väga motiveeritud ja koostööaldis, et võib-olla sellepärast see teenus ka aitas.“

Tagasiside lapsevanematelt

- „Võib-olla oleks abi olnud sellest, kui spetsialistid teeksid koduvisiite.“
- “Teenuse juures olekski võinud olla teisiti see, et esmakohtumine oleks pidanud toimuma ainult ühe spetsialistiga korraga, mitte terve rehabilitatsioonimeeskonnaga – võib-olla siis oleks tütar hakanud teenusel käima.”
- „Teenuse juures jäi puudu võrgustikutööst, ema ütleb, et tema ei teadnuki seda, et tütar teenusel ei käinud, et ema teavitati sellest väga harva, kui tütar kohale ei ilmunud. Teenuste tühistamine käis läbi tütre ja ema ei olnud sellega üldse kursis.“
- „Teenus peaks olema täiesti lapsest sõltuv ja vajaduspõhine, et kõik lapsed on erinevad ja igale ei sobi see sekkumine, mis võib enamusele sobida.“

Uurisime ka laste teenusele mitte jõudmise põhjuseid:

KOVi kui juhtumikorraldaja rolli hägusus:

- Lastekaitsetöötaja arvas, et perega võetakse ise ühendust ja seetõttu jäi asi katki, teeb uue taotluse.
- Lastekaitsetöötaja ei olnud teenusele suunamist vanemaga läbi arutanud, vanem keeldus.
- Lapsevanemad ei olnud motiveeritud, seetõttu ei toodud ka last teenusele, kuigi KOV pakkus ka sotsiaaltransporti selle jaoks.

Mobiilse ja paindliku teenuse puudus:

- Poiss võeti ajutiselt internaatkooli.
- Laps viidi üle teise asenduskodusse.
- Vanematel on olnud valmisolek e-kirja teel psühholoogiga kontakti hoidmiseks. Laps ise

aga teenusele kohale ei jõua. Takistavaks teguriks on olnud ka lapse liikumine kahe vanema vahel.

Teenuse osutamisel ühtse kvaliteedistandardi järgimise puudumine

- Lapsel oli hinnatud psühholoogi teenuse vajadus, kuid teenuse raames puudus sisuline töö, lapsevanem vahetas teenusepakkujat ja on uues kohas rahul.
- Pere soovis minna *konkreetses teenuseosutaja* juurde, kuid seal oli järjekord, pere ärevus tõusis selle ajaga ja siis pere enam ei soovinud teenust.

Meie tegevused sihtgrupi täpsemaks kirjeldamiseks

- SRT teenusel oleva lapse abivajaduse tunnused
<https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse#indikatorid>
- Koondasime KOVi lastekaitsetöötaja jaoks info, kuidas ja keda teenusele suunata, mida selleks tegema peab. Info leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.
- Andsime KOVidele ja kootööpartneritele sõnumi, et oleme valmis teenusele suunamisel juhtumipõhiselt nõustama ja igakülgsest toetama.

Tegevused teenuse arendamiseks

- Leidsime teenuseosutaja Jõgevamaale ja Põlvamaale, kes on valmis pakkuma teenust ka abivajava lapse sihtgrupile.
- Värskest on lisandunud ka teenusepakkuja Võrumaale – Rõuge Koostöökeskus.
- Puudu on veel teenuseosutaja Hiiumaal, kuid oleme alustanud läbirääkimisi erinevate osapooltega võimaluste leidmiseks.

Tegevused teenuse arendamiseks

- Osalesime lastekaitsetöötajate infopäevadel (viies maakonnas), et tõsta teadlikkust abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osas. Plaanime ka teha oma infopäevad ja piirkondlikud kohtumised, et luua lastekaitsetöötajatega otsekontakt.
- Teeme tihedat koostööd Sotsiaalministeeriumiga, et olla teenuse arendamise vaates ühel meelel ning rääkida kaasa erivajadustega laste tugisüsteemide arendamise teemal.
- Organiseerisime rehabilitatsiooniastustele nii supervisiooni kui ka kovisiooni ning läbi selle oleme saanud häid mõtteid teenuse arendamise ja partnerite toetamise osas.
- Oleme loonud teenuseosutajatega otsekontakti, et mõista nende ootusi ja olla neile toeks teenuse pakkumisel.

I töötoas selgunud teenuse ideaal ja probleemid

IDEAAL

- Toimiv võrgustikutöö mudel.
- Üks vastutav juhtumikorraldaja.
- Selge sihtgrupp, kes on abivajav laps SRT teenuse vaates?
- Ühine infosüsteem, infoväli.
- Lapse vajadustest lähtuv teenus, avatud teenuste nimekiri.
- Pädevad spetsialistid, täiendkoolitused, spetsiaalne õppekava.
- Ühtne ja arusaadav hindamissüsteem.

PROBLEEMID

- Teenusele eelnev on ebaselge ja ebaühtlane (ennetustöö).
- Puudub üheselt arusaadav teenuse eesmärk ja kirjeldus (kvaliteedi standard).
- Puudub riiklik personali strateegia/nõuded.
- Vähene teadlikkus teenusest.
- Ühiskonna mentaliteet (stigmad).
- Teenuseosutajate ebaühtlane võimekus.
- Mitte töötav hindamisinstrument.
- Teenuse kättesaadavus.
- Lapse vajaduste ja võimalustega arvestamine.
- Võrgustikutöö koordineerimise oskuse puudus.

II töötuba – kliendi profiilid ja teekonnad

- II töötoas kaardistasime koostöös erinevate osapooltega kahe abivajava lapse profiilid ja teenuse teekonnad.
- Kuigi koostasime kaks erinevat profiili, erinevates töögruppides, joonistusid välja siiski samad abivajaduse tunnused, sarnane peretaust ning ühtse tugisüsteemi puudumine.
- Tekkinud laste profiilide peamiseks muredeks olid koolikohustuse mittetäitmine, hulkumine, hirm ja oskamatus suhelda teistega, nutisõltuvus, varastamine, väiksed õigusrikkumised, ATH ja autistlikud jooned käitumises, vähene peretugi ja lapsevanema vähesed vanemlikud oskused ning perevägivalla kogemine/pealt nägemine ning võimalik sõltuvusainete tarvitamine.

III töötuba – teenusekirjelduse koostamine

- Kolmas töötuba toimus eile, 15.oktoobril.
- Osalesid lastekaitsetöötajad, rehabilitatsiooniteenuse osutajad, laste tugiteenuste pakkujad, SKA osakondade esindajad (järelevalve, lastekaitse osakond, teenuste osakond, MDFT). Esindatud oli ka prokuratuur, Sotsiaalministeerium ning üks lapsevanem.
- Töötoas keskenduti abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusekirjelduse koostamisele.

Võttes arvesse tagasisidet erinevatelt seotud osapooltelt, siis meil on plaanis...

- Arendada abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust selliselt, et kõik abivajavad lapsed, kes on õigustatud teenust saama, saaksid kvaliteetset ja vajaduspõhist teenust sõltumata oma asukohast.
- Ühtlustada teenuseosutajate pädevusi traumakogemusega lapse toetamisel (traumakoolitus rehabilitatsiooniasutuste psühholoogidele).
- Teenusteülene riskihindamisvahend (KLAT-MDFT-SRT), mis oleks kättesaadav ja lihtsasti täidetav KOVi lastekaitsetöötajale STAR keskkonnas ja mille juurde valmiks ka tegevuskava.
- SKA poolne teenuste koordinaator, kes aitaks hoida silma peal abivajava lapse rehabilitatsiooniteenuse teekonnal ning oleks juhtumikorraldajale (KOV) vajadusel toeks.

Lisainfo saamiseks

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehel abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rubriigist.

<https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse>

Teenuse koordinaatoritelt:

✓ Simone Epro, Telefon: +372 518 0567

simone.epro@sotsiaalkindlustusamet.ee

✓ Laura Kane, Telefon: +372 5880 5726

laura.kane@sotsiaalkindlustusamet.ee

Aitäh!



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Oluline teada rehabilitatsiooniteenuse tegevusloa taotlemisel ja muutmisel

Ülle Tiits

Järelevalve talitus

Kvaliteediosakond

16.10.2020

Ole kättesaadav

- Kontrolli aeg-ajalt, kas tegevusloal teenuseosutaja kontaktandmed on õiged, st pööra tähelepanu
- kontakttelefonile, mis vastab ka siis, kui töötaja on haige või puhkusel
- e-posti aadressile, mis kehtib ka siis, kui töötaja on töölt lahkunud
- Kasuta nuppu – muuda kontaktandmeid

Taotleja kommentaar

- Ära kirjuta pikalt, kes tuli, kes läks
- Kasuta üldsõnalist kommentaari
- Kontrolli, et uuele taotlusele ei jääks eelmise taotluse kommentaar

Tegevuskoha täpsustuse lahtrisse kirjuta

- Oluline info, mis on seotud selles tegevuskohas teenuse osutamisega (mis hõlbustab hoone leidmist lisaks aadressile)
- Info, mis on seotud mingi teenuseliigi osutamisega mujal (näit psühholoog osutab vajadusel teenust lasteaias aadressil...)
- Ära kirjuta sinna, mis muutust soovid teha

Meeskonnaliikmete lisamine

- Meeskonnaliikmete all nupp – lisa spetsialist
- Isiku andmete lehel sisesta isikukood ja vajuta – otsi isikut.
Nimi tuleb RR-st
- Kontakttelefon ei pea olema isiklik number
- E-posti aadress ei pea olema isiklik aadress

Meeskonnaliikmete kustutamine

- Kui spetsialist lahkub meeskonnast – paremal kiri - kustuta rida
- Ära vajuta nupule- tühjenda
- Jälgi, kas meeskonnaliikmete erialad ja „linnutatud“ teenused on vastavuses

Meeskonnaliikme haridus

- Sobivad erialad nimetatud SHS §-s 68
- Oluline – kas kutsetunnistus või riiklikult tunnustatud kõrgharidus
- Välisriigis omandatud kõrgharidus – vajalik ENIC/NARIC hinnang hariduse vastavuse kohta riiklikult tunnustatud kõrgharidusele
- Kui ainult erialane täiendkoolitus – ei sobi

Meeskonnaliikme haridus 2

Hariduse sisestamisel vajuta – otsi haridust

- Kui haridusregistris kanne puudub, vajuta – sisesta käsitsi
- Õppekava vali valikutest
- Õppeasutus vali valikutest
- Hea, kui lisad haridust tõendava dokumendi

Meeskonnaliikme koolitused

Alates 1.01.20 peab vähemalt ühel meeskonnaliikmel olema läbitud rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (SHS § 160 lg 15)

- Kui vähemalt ühel meeskonnaliikmel on sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala – ei ole see koolitus kohustuslik

Meeskonnaliikme koolitused 2

- Kui teenuseosutajal on mitu meeskonda, käib eelnimetatud nõue iga meeskonna kohta
- Koolituse kohta ei ole eraldi väljasid, märgi see hariduse alla – nupp - Lisa

Meeskonnaliikme kutsetunnistus

- Kutsetunnistuse lisamiseks vajuta – otsi kutseregistrist
- Jälgi kutsetunnistuse kehtivust
- Isiku andmete lehel muutub kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse number punaseks
- Kontrolli, kas on uut kehtivat kutsetunnistust või on muu õiguslik alus kuuluda meeskonda

Alates 1.01.2020 ei tohi enam meeskonda kuuluda

- Pedagoog
- Tegevusterapeudi assistent (v.a juhul, kui õpib kõrgkoolis tegevusterapeudiks)
- Alus: SHS § 160 lg 15

Eripedagoog - logopeed

- Kui diplomil on nimetatud eripedagoogika eriala, võib meeskonda kuuluda eripedagoogina
- Kui diplomil on nimetatud logopeedia eriala, võib meeskonda kuuluda logopeedina
- Kui magistriõppes on läbitud eripedagoogika ja logopeedia õppekava, võib meeskonda kuuluda nii eripedagoogi kui logopeedina

Tegevuskoha muutmine või lisandumine

- Kui lisandub uus tegevuskoht, vajuta olemasoleva tegevuskoha all kirjale – lisa tegevuskoht
- Kui tegevuskoht kaob ära – vajuta tegevuskoha all kirjale – kustuta kirje
- Igas tegevuskohas peavad olema vajalikud tõendid ja vähemalt 3-liikmeline meeskond, kellest üks on sotsiaaltöötaja ja vähemalt üks läbinud spetsialisti baaskoolituse

Tegevuskohale vajalikud tõendid

- Terviseameti tõend, et teenuse osutamise ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele ja võib osutada rehabilitatsiooniteenust (isikute arv?)
- Päästeameti tõendit ei ole vaja, kui
- hoone kasutusotstarve on sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus, tugikodu, lastekodu,

Tegevuskoha vajalikud tõendid 2

- noortekodu, üldhooldekodu, koolkodu, erihooldekodu, haigla, kinnipidamiskoha haigla, ambulatoorse arstiabi osutamise ehitis
- Muu kasutusotstarbega hoonel ei ole vaja tuleohutusnõuetele vastavuse hinnangut juhul, kui teenust osutatakse korraga vähem kui 10 inimesele

Täpsustavad andmed

- Täida juhul, kui on midagi olulist lisada (nt tegevusterapeudi assistent Mari Maasikas õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis III kursusel tegevusterapeudiks)
- Ära kirjuta, kes tuli meeskonda juurde või läks ära

Ära unusta

- Salvestada ka siis, kui liigud taotluse vormi erinevate lehtede vahel
- Salvestada ka siis, kui kõik on valmis
- Vajutada nupule – esita
- Kui nupp – esita – ei anna vajutada, kontrolli tehtu üle, kuskil on midagi täitmata jäänud

Oluline meeles pidada

- Tegevusloa omajal on kohustus teavitada tegevusloa väljaandjat tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate andmete või kõrvaltingimuste muutusest viivitamatult või hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (MSÜS § 30 lg 2)
- Inimkeeles – saada tegevusloa muutmise taotlus kohe, kui andmed muutuvad (kontaktandmed, tegevuskoht, meeskond)



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Aitäh!

Ülle Tiits

5188 697

ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalne rehabilitatsioon arvudes

Kati Karelson

finants- ja arendusosakond, analüüsitalitus

analüütik

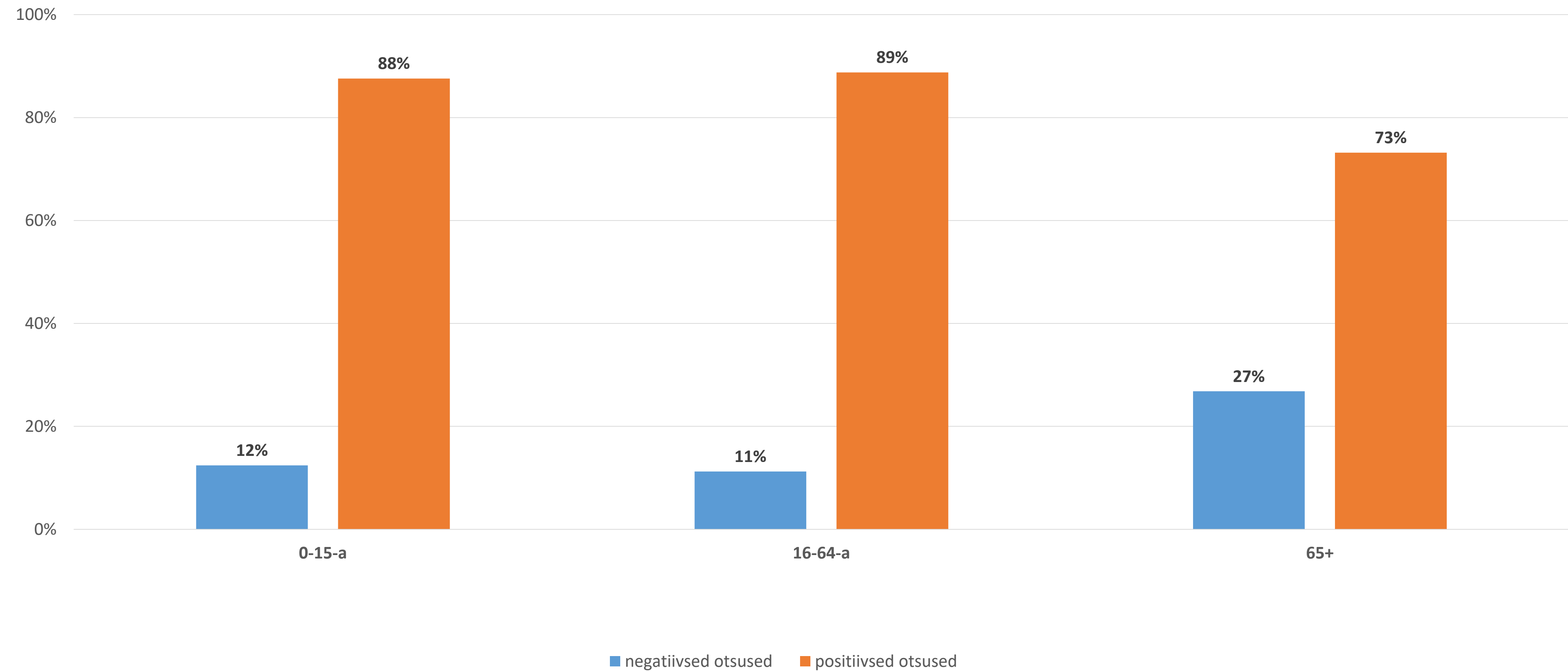
SRT taotluste arv aastas

2019. aastal esitati sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamise taotlus
6212 isiku kohta.

Positiivse otsuse said 5362 isikut (86%)

ja negatiivne otsus tehti 850 isikule (14%).

Positiivsed ja negatiivsed otsused vanuse järgi, 2019



SRT saajad soo ja vanuse järgi

2019. aastal sai sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust

~ 10200 isikut,

kellest **mehi oli 58% ja naised 42%**

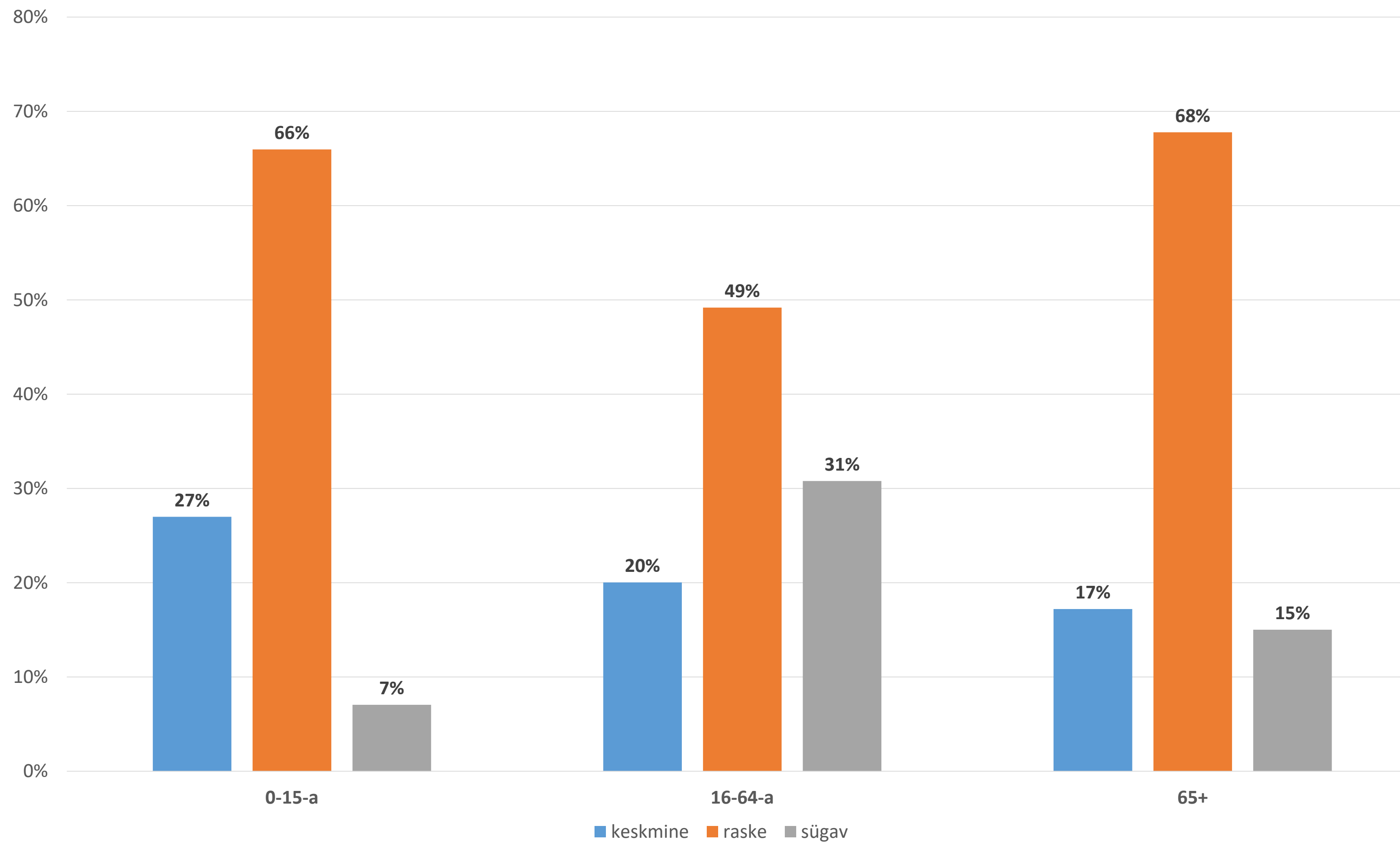
Teenusesaajatest **2/3 olid lapsed.**

SRT saajad puude liigi järgi

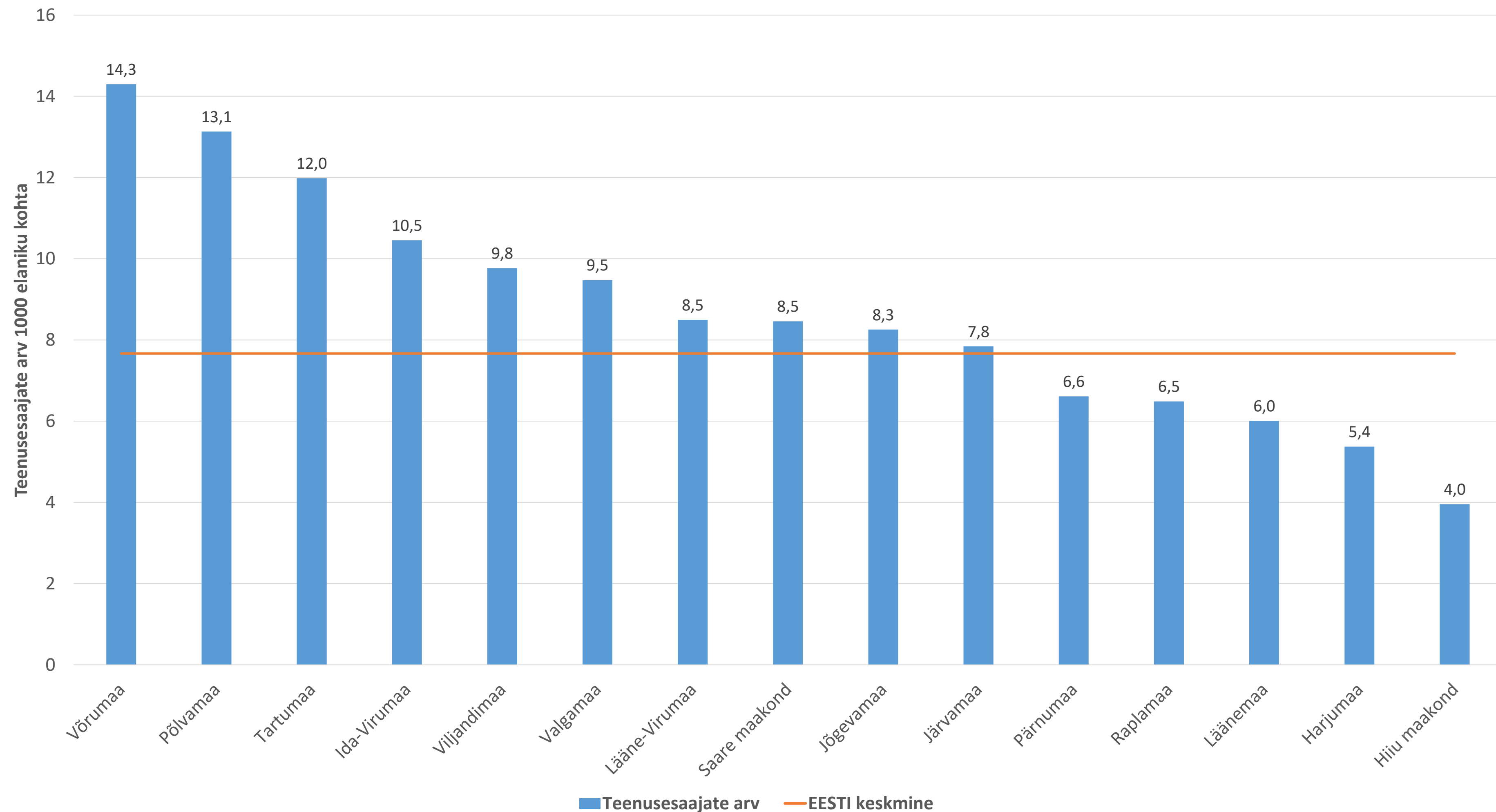
Kaks kõige suuremat puude liiki on:

- **0-15-aastastel** psüühikahäire ja liitpuue – **kokku 62%**
 - **tööealistel** psüühikahäire ja liitpuue – **kokku 77%**
- **65-aastastel ja vanematel** liikumispuue ja liitpuue – **kokku 84%**

SRT saajad puude raskusastme järgi



SRT saajate arv 1000 elaniku kohta maakonna järgi, 2019



SRT saajad vanuse ja maakonna järgi – „pingerida“

Mida väiksem % elanikest SRT on saanud seda **rohelisem** värv

	0-15	16-63	64+	Kogu rahastik
Harjumaa	14	13	11	14
Hiiumaa	15	15	10	15
Ida-Virumaa	2	9	3	4
Jõgevamaa	9	7	6	9
Järvamaa	7	8	14	10
Läänemaa	12	11	15	13
Lääne-Virumaa	6	10	13	7
Põlvamaa	1	2	4	2
Pärnumaa	13	12	7	11
Raplamaa	11	14	12	12
Saaremaa	10	4	9	8
Tartumaa	3	6	5	3
Valgamaa	4	5	8	6
Viljandimaa	8	3	2	5
Võrumaa	5	1	1	1

Teenuse tundide jaotus vanuse järgi, 2019

Teenus	0-15-a	16-64-a	65+
füsio ind	12%	7%	25%
tegevusterapeut ind	7%	10%	12%
loovterapeut ind	8%	7%	3%
sotsiaaltöötaja ind	9%	14%	16%
eripedagoog ind	17%	6%	2%
psühholoog ind	17%	16%	17%
logopeed ind	17%	2%	1%
kogemusnõustaja ind	2%	1%	2%
õde ind	2%	1%	3%
arst ind	0%	1%	3%
füsio grupp	1%	2%	7%
tegevusterapeut grupp	0%	10%	2%
loovterapeut grupp	1%	1%	0%
sotsiaaltöötaja grupp	0%	6%	2%
eripedagoog grupp	0%	1%	0%
psühholoog grupp	1%	9%	2%
logopeed grupp	0%	0%	0%
kogemusnõustaja grupp	1%	3%	1%
õde grupp	1%	0%	0%

Kuidas toetada analüütika abil valdkonna arendusi?

RIIGIHANGE

**Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
tulemuslikkuse hindamise metoodika väljatöötamine ja
tulemuslikkuse hindamine Sotsiaalkindlustusametile**

Kes? Mis? Millal?

PARTNER: Tartu Ülikool (Rake)

TEEMAD

asjakohasus
tulemuslikkus
mõju kestus
kulutõhusus

metoodika SKA-le
mõjuanalüüs
ettepanekud

TULEMUSED

AJAKAVA:

2020						2021					
07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
lepingupartneri tegevuste kestus: 10 kuud										tulemuste esitlus	

Aitäh!

Kati.Karelson@Sotsiaalkindlustusamet.ee



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Olulised ülevaated rehabilitatsiooni korraldusest

Helen Tähtvere

Sotsiaalkindlustusamet

erihoolekande- ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja

01. juulist kujundasime ümber erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja ametikoha, mille tulemusena on meil täna:

8 teenuste koordinaatorit, kelle tegemised jagunevad maakonnapõhiselt
28 teenuste konsultanti, kelle tööd jagunevad asutuste põhiselt

Teenuste koordinaator:

- loome asutusesisese kompetentsi kvaliteedi edendamiseks;
- koostöös teenuseosutajatega tagame kvaliteetse ja nõuetekohase teenuste osutamise;
- tihendame koostööd võrgustikuparteritega
- toetame/nõustame teenusekohtade küsimustes

Teenuste konsultant:

- hindame inimese abi- ja toetusvajadust;
- koostöös teenuseosutajaga hindame ja analüüsime inimese teenuse tulemuslikkust;
- tegeleme inimese teenusele suunamisega ning kõigi teenusel või järjekorras olevate inimeste murede/rõõmudega



Kontaktid:

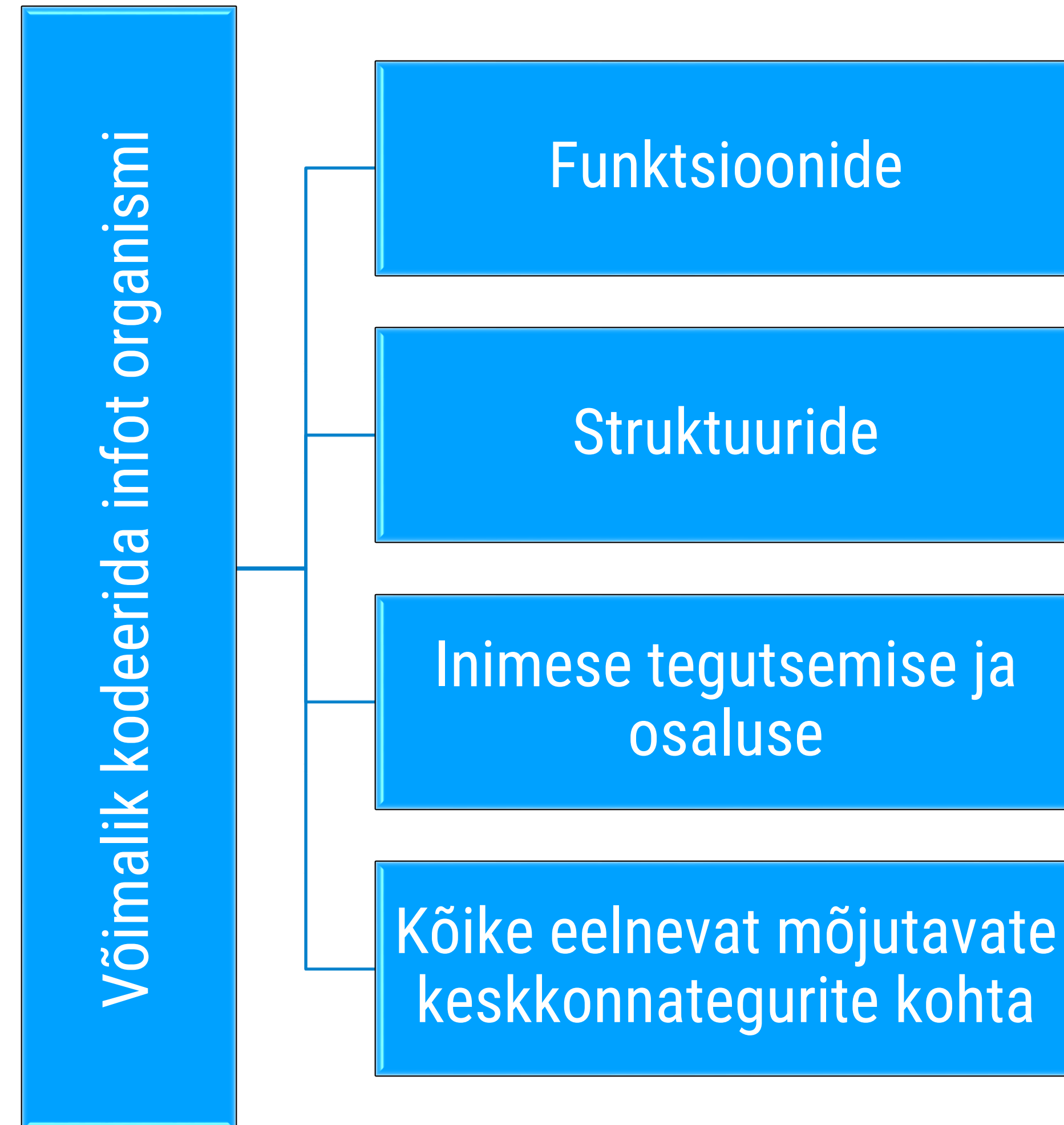
<https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuse-osutajale#koordinaatorid>

Kontaktid: [https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-](https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/sotsiaalteenuste-osakond-ja-teenuste-konsultantide)

[hoolekanne/erihoolekandeteenused/sotsiaalteenuste-osakond-ja-teenuste-konsultantide](https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/sotsiaalteenuste-osakond-ja-teenuste-konsultantide)

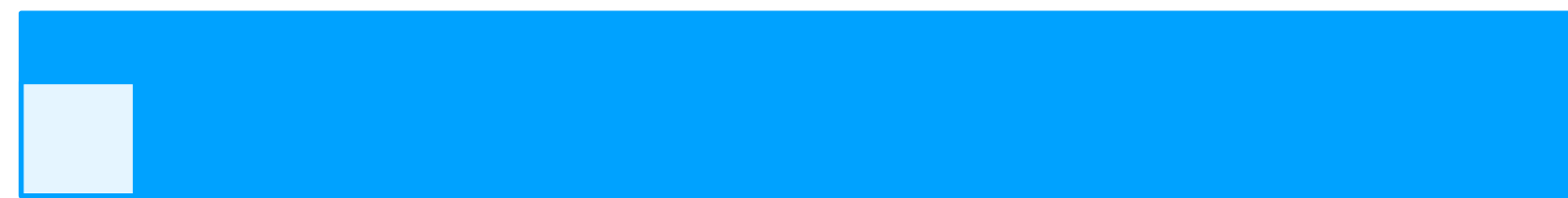
RFK ehk rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon

Eesmärk on anda ühtne standardkeel ja -raamistik tervise ja tervisega seotud seisundi kirjeldamiseks



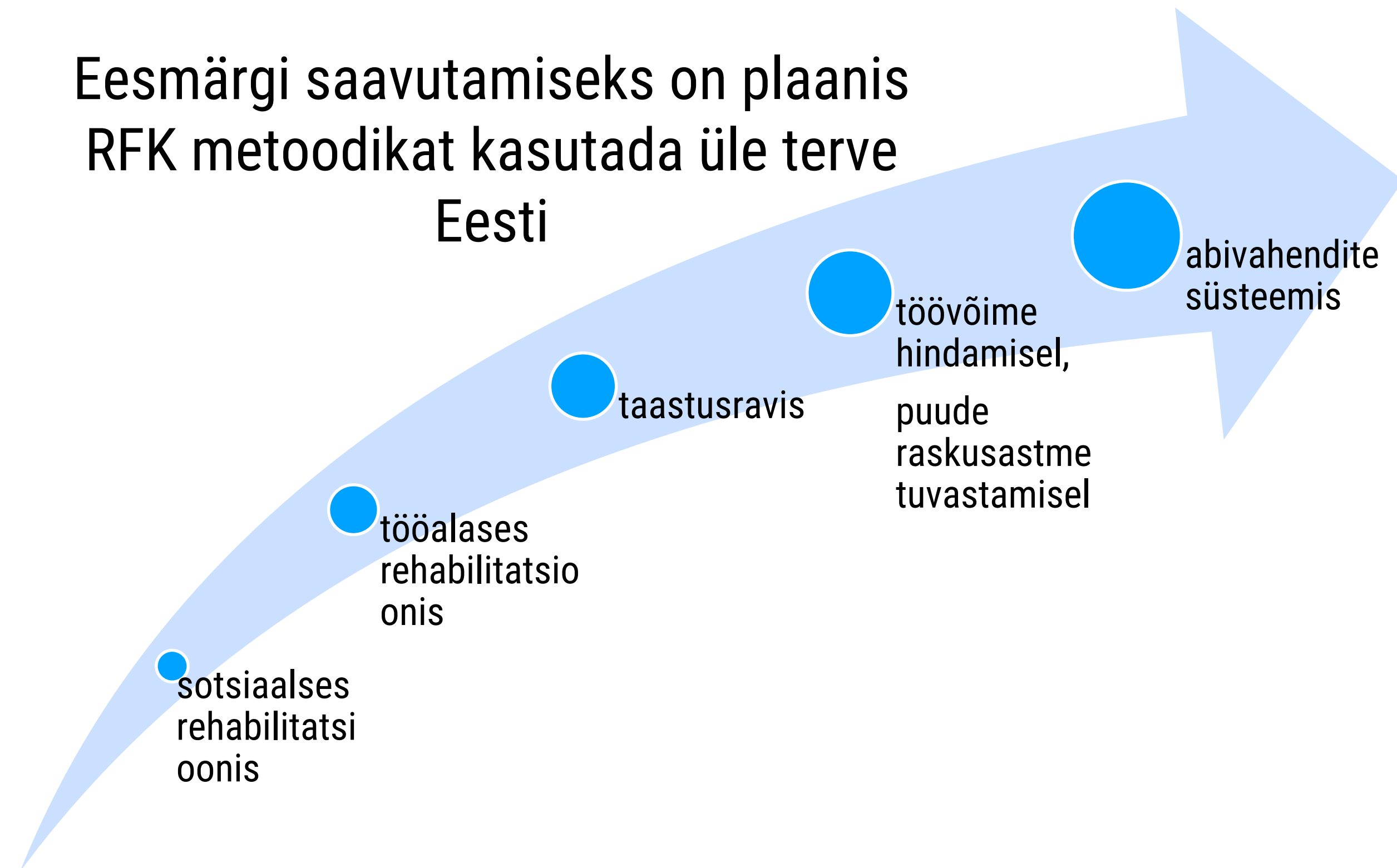
Tegevused RFK kasutusele võtmiseks

SKA tegevused 2021-2022



- ☐ Eestikeelse tõlke ja juhendmaterjalide kaasajastamine
- ☐ Koolitajate ja valdkonna spetsialistide koolitused koostöös Töötukassaga
- ☐ Ärianalüüs üleriigilise RFK rakendamiseks valdkondade üleselt, mis on infosüsteemide edasiarenduse aluseks

Eesmärgi saavutamiseks on plaanis
RFK metoodikat kasutada üle terve
Eesti



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Abi- ja toetusvajaduse hindamisvahend

Eluvaldkonnad	1. sotsiaalsed suhted – 1 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks;
	2. vaimne tervis – 3 küsimust toetusvajaduse astme määramiseks;
	3. füüsiline tervis – 3 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks;
	4. hõive – 1 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks;
	5. vaba aeg ja huvitegevus – 1 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks;
	6. elukeskkond – 1 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks;
	7. igapäevatoimingud – 5 küsimus toetusvajaduse astme määramiseks.

Inimese vajaduste (toetusvajaduse) tuvastamiseks kasutatava hindamisvahendi välja töötamise aluseks on elukvaliteedi valdkonnad, mis tuginevad Maailma Terviseorganisatsiooni poolt soovitatud spetsiifilisele elukvaliteedi instrumendile - WHOQOL (The World Health Organization Quality of Life Instruments)



Toetusvajaduse astmed

Toetusvajaduse astmed

Aste	Toimetulek	Toetusvajadus
0	Iseseisev	Ei vaja toetust.
1	Madal toetusvajadus	Toimetulek kergelt häiritud. Vajab meeldetuletust ja nõustamist
2	Keskmine toetusvajadus	Toimetulek mõõdukalt häiritud. Vajab regulaarset (1-4 korda nädalas) juhendamist ja abi.
3	Kõrge toetusvajadus	Toimetulek raskelt häiritud. Vajab igapäevaselt kõrvalabi ja toetust.
4	Äärmuslik toetusvajadus.	Võimetu toime tulema v tegelema. Vajab püsivalt hooldust ja/või järelevalvet või tegevuste üle võtmist teise isiku poolt.



D-osa tulevik = teenuse kokkuvõttev hinnang?

D-osa

- Määruses sõnastatud
- Paljusõnaline
- Soovituslik vorm olemas
- Raske hinnata teenuse mõju

Kokkuvõttev hinnang teenuse osutamise kohta

- SKA kodulehel vorm: <https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/erihoolekandeteenuse-osutajale>
- Struktuurne, toetusvajaduse astmed, hinnangud/põhjendused juures
- Lihtne hinnata teenuse mõju. Oluline nii inimesele, teenuseosutajale kui ka SKA-le
- Ka KOV-id võtavad kasutusele



Kellel huvi, siis meie poolt kontakt nõunik Helis Eesmaa, e-post: helis.eesmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee; tel: 5782 6470



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Eriolukorra õppetunnid ja tagasiside teenuseosutajatelt

Helen Tähtvere

Sotsiaalkindlustusamet

erihoolekande- ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja

Milliseid uuendusi eriolukorras kasutusele võtsite?

70 asutust võtsid aktiivselt kasutusse telefoni teel nõustamise

59 asutust võtsid kasutusele videosilla

28 asutust võtsid töösse pereliikmete juhendamise ja nõustamise

23 asutust võtsid kasutusele distantstilt juhendamise

16 asutust võtsid koduste ülesannete andmise töösse

16 asutust alustasid digilahenduste õpetamisega teenusesaajatele

13 asutust korraldasid õppetöö toetamist video teel.

11 astust ei näinud vajadust uudsete lahenduste järele

4 asutust olid eriolukorra ajal suletud

Lisaks toodi välja:

- ✓ tehti tööd välitingimustes
- ✓ koostati juhendmaterjale
- ✓ üks asutus avas nõustamistelefoni psühholoogilise toe saamiseks.
- ✓ Üks asutus märkis, et video ja telefonijuhised erivajadustega lastele ei töötanud, kuna nad ei suutnud olla tähelepanelikud. Lisandusid ka videoülesanded inimestele

Vastused 156 asutuselt



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Milliste uuendustega jätkate peale eriolukorda?

46 asutust - Video kasutamist nõustamisel ja juhendamisel.

45 asutust - Telefoni kasutamist.

26 asutust - Pereliikmete juhendamist nõustamist.

21 asutust - Digilahenduste õpetamist.

18 asutust - Distsantsilt juhendamist.

11 asutust - Koduste ülesannete andmist.

7 asutust - Õppetöö toetamist video teel.

33 asutust - said enne said hästi hakkama ja uusi lahendusi jätkuvalt ei hakka kasutama

46 asutust - Video kasutamist nõustamisel ja juhendamisel.

Vastused 156 asutuselt



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Kas Teie asutuses on välja töötatud COVID-19 kahtluse korral käitumise juhend ning seda on tutvustatud töötajatele?

76 asutusel on juhend olemas, töötajad saavad sellega iseseisvalt tutvuda.

21 astutust ei näe vajadust juhendi järgi, kuna puudub oluline COVID19 oht

18 asutusel on olemas kriisis käitumise juhendid

18 asutusel on juhend olemas ning töötajad saavad ise sellega tutvuda

10 asutust on oma töötajaid juhendanud suuliselt ja viirusega seotud käitumise läbi arutanud

10 asutust jälgivad oma töös SKA ja Terviseameti saadetud juhendeid

76 asutusel on juhend olemas, töötajad saavad sellega iseseisvalt tutvuda.

21 astutust ei näe vajadust juhendi järgi, kuna puudub oluline COVID19 oht

18 asutusel on olemas kriisis käitumise juhendid

Lisameetmed, mida asutused haiguse levimise vältimiseks kasutavad:

- Kasutatakse kontaktivaba kehatemperatuuri mõõtmist nii töötajatele kui teenusel olevetele inimestele.
- Teavitatakse inimesi pidevalt, et haigustunnustega tuleb koju jääda.
- Tervisedeklaratsiooni täitmine enne teenusele asumist.
- Nõutakse IKV kasutamist nii klientidelt kui töötajatelt.
- Hoitakse distantsi.
- Pestakse ja desinfitseeritakse käsi.
- Enne ruumi sisenemist tuleb lugeda käitumisjuhendit.



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Isikukaitsevahenditega varustatust hinnatakse järgmisel (skaalal 1-10):

1 asutus hindas varustatuks nii halvaks, et see häirib väga töö tegemist. (1 punkt)

2 asutust hindas varustatust alla keskmise, mis võib takistada nakkuse uue leviku korral töö tegemist, puudub varustus paari kuu jaoks. (2-4 punkti)

21 asutust hindas varustatust keskmiseks (5-7 punkti) siin toodi välja, et kui uusi kliente tuleb rohkem, siis võib olla keeruline toime tulla maskide varuga. Samuti nähti võimalust vajadusel juurde tellida makse, põllesid ja kaitseülikondi.

133 asutust hindavad varustatust heaks või väga heaks (8-10 punkti).

Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (I)

108 asutust - Info oli asjakohane ja aitas oma tegevusi planeerida, kuid eriolukorra lõppedes saabus info hilinemisega.



40 asutust hindasid, et infot oli palju ja see kordus, toodi välja et raske oli aru saada milline info millise teenuse kohta kehtib.



Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (II)

IKV

- IKV vähesus riigis ja aeglane abistamine nendega varustamisel, eriti eriolukorra alguses.
- Eriolukorrast väljumisel oleksime oodanud toetust isikukaitsevahendite osas või materiaalsel abi nende kompenseerimisel. Ootaksime seda ka praegu.

Juhised

- Juhised oleks võinud kiiremini valmida.
- Piisab kui SKA viitab terviseameti lehe infole, ei ole vaja dubleerida.
- SKA poolt oodati rohkem juhiseid.

Info

- Vajalikku infot oli raske hankida.
- SKA oleks võinud paremini reguleerida infovoogusid. Eriolukorral oli ka teisi ametkondi, kes helistasid ja tahtsid infot. Kõige parem, kui oleks üks ametkondade ülene kontakt, kellele vastata.
- Infot eri asutustelt tuli sama sisuga. Seda oli aeganõudev läbi töötada.
- SKA reageeris aeglaselt, kuid infot levitati põhjalikult.



Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (III)

Avaldati rahulolu, et telefoni protokolle ja kaugnõustamist aktsetpeeriti.

Info oli operatiivne ja vastavalt olukorrale. Probleemid lahendati kiiresti ja infovahetus toimus hästi.

Hea, et juhised olid koos piltidega ja juhtumikorraldaja helistas pidevalt.

Kiideti IKV varustamist.

Kiideti juhtumikorraldajatega koostööd.

Iganädalane kõne oli toetav ja abiks, saadi aru, et SKA tunneb huvi ja nõustab vajadusel.



Aitäh!



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET